

Agenda de Recherche et d'Action pour l'Amérique Latine et les Caraïbes

Liste des auteurs

Dr Natalie Greaves, maîtresse de conférences en santé publique, coordinatrice du MPhil/PhD en santé publique et épidémiologie, Faculté des sciences médicales, Université des Indes occidentales (UWI) Cave Hill.

Dr Satish Jankie, maître de conférences en pharmacologie, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine

Dr Shamjeet Singh, maître de conférences en sciences fondamentales intégrées de la santé, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine

Ambassadrice Gillian M. S. Bristol, Directrice, Latin American Caribbean Centre (ALC), UWI Mona

Dr Elizabeth Mandeville, Consultante Indépendante

Dr Michael Campbell, maître de conférences en sciences du comportement/psychologie et vice-doyen (recherche et études supérieures), UWI Cave Hill

Nienke Meinsma, chargée de cours sur le changement climatique et la santé, Climate Cares Centre, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Jessica Newberry Le Vay, chargée de recherche sur le changement climatique et la politique de santé, Climate Cares Centre, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Didi Thompson, chercheur honoraire, Centre for Health Policy, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Dr Emma J. Lawrance, Climate Cares Centre, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Dr Sandeep Maharaj, Directeur, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine

Table des matières

Résumé Exécutif	3
Introduction	6
Historique de Connecting Climate Minds	8
Méthodologie	11
État actuel et nécessités émergents en matière de changement climatique et de santé mentale en Amérique Latine et Caraïbes	17
Agenda de recherche	21
Thèmes de recherche prioritaires	21
Programme d'action	26
Discussion : Points forts, limites et prochaines étapes du programme de recherche et d'action	34
Conclusion	36
Audition de la communauté de pratique régionale	37
Glossaire	38
Qui a produit ce rapport	38
Annexe	43
Références	61

Résumé Exécutif

De nombreux Petits États Insulaires en Développement (PEID) du bassin caribéen et des pays du continent latino-américain sont confrontés à des défis économiques et environnementaux liés au changement climatique.¹ Cependant, le changement climatique est également de plus en plus reconnu comme une menace pour la santé mentale, aggravant les risques de mauvaise santé mentale et déstabilisant les conditions nécessaires à une bonne santé mentale. Bien que les recherches à l'intersection du changement climatique et de la santé mentale aient proliféré ces dernières années, le domaine reste déconnecté, inégal et cloisonné, ce qui ralentit les progrès urgents pour aborder les impacts du changement climatique sur la santé mentale et la compréhension des avantages de l'action climatique pour la santé mentale.

Connecting Climate Minds (CCM) est une initiative financée par Wellcome qui vise à favoriser une collaboration transdisciplinaire dans le domaine du changement climatique et de la santé mentale, avec une vision claire et cohérente. Au cours de la dernière année, nous avons réuni des experts dans un éventail de disciplines, de secteurs et de pays afin d'élaborer des programmes de recherche et d'action régionaux et mondiaux. Ces agendas définissent : 1) un cadre d'enquête pour identifier, comprendre et répondre aux besoins des personnes qui subissent les conséquences de la crise climatique sur leur santé mentale ; et 2) les priorités en matière de recherche et de translation des évidences en actions dans la politique et la pratique.

Ce rapport présente une proposition d'agenda de recherche et d'action sur le changement climatique et la santé mentale en Amérique Latine et dans les Caraïbes (ALC).

Un examen de la portée réalisé comme étape fondamentale de ce projet a révélé un nombre limité d'études dans la région ALC portant sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale. Les recherches existantes fournissent des informations importantes fondées sur les contextes culturels et historiques du climat et de la santé mentale dans la région ALC.^{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11} Cependant, de nombreuses études ont été menées après des catastrophes cycloniques majeures et ne prennent pas en compte de manière plus ample l'impact de la crise climatique sur la santé mentale. La littérature identifiée se concentre principalement sur les effets négatifs sur la santé mentale dus à des événements climatiques extrêmes aigus dans le contexte a) de la gravité des traumatismes/pertes observés/expérimentés, et b) des vulnérabilités socio-économiques sous-jacentes.^{2, 3, 4}

Dans la région ALC, le risque d'être exposé à des problèmes de santé mentale liés au climat varie selon les zones géographiques, les caractéristiques démographiques personnelles et les caractéristiques socioculturelles. Toutefois, les peuples autochtones, les minorités ethniques, les économies côtières et les communautés agricoles, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes souffrant déjà de problèmes de santé mentale semblent les plus vulnérables aux problèmes de santé mentale liés au climat. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les médecines traditionnelles et les réponses communautaires, y compris celles des groupes religieux et de ceux qui croient en une puissance au-delà de l'humanité, peuvent être des outils utiles pour relever les défis en matière de santé mentale et de bien-être liés au changement climatique dans la région.

Les thèmes de recherche prioritaires pour la région couvrent une multitude de domaines, notamment :

- Comprendre et définir les concepts de vulnérabilité et de résilience en matière de santé mentale liée au climat ;
- Définir des termes diagnostiques clés tels que l'éco-anxiété ;
- Quantifier le fardeau « supplémentaire » de la santé mentale associé à la crise climatique ;
- Les disruptions dans les parcours de soins de santé mentale résultant de la crise climatique ; et
- Comprendre les voies et les mécanismes par lesquels la crise climatique affecte la santé mentale en ALC, y compris :
 - La mesure dans laquelle les modulations des indicateurs socio-économiques ou de développement humain liés à la crise climatique donnent lieu à des problèmes de santé mentale ou à des distorsions du bien-être mental ;
 - L'impact de la chaleur sur les résultats en matière de santé mentale, y compris les états dépressifs et l'incidence de l'automutilation ou de la mort par suicide ;
 - La distorsion du rythme circadien liée au climat en raison des changements dans les conditions de vie et de sommeil, et l'incidence connexe d'un mauvais bien-être mental ou d'effets sur la santé mentale chez les enfants et les populations autochtones (il s'agit des groupes identifiés comme étant vulnérables à ce problème, mais il est probable qu'il soit beaucoup plus répandu) ; et
 - Changements de cortisol liés au climat et apparition du stress.

La mise en œuvre d'un programme de recherche en Amérique latine et dans les Caraïbes nécessitera une recherche respectueuse, adaptée au contexte et à la culture. Les approches participatives de la recherche seront cruciales, avec la participation des populations autochtones, des jeunes et des organisations de la société civile (en particulier où les structures formelles de gouvernance nationale sont fragiles). L'engagement de membres de la communauté non professionnels en tant que cocréateurs, exécutants et diffuseurs de la recherche sera important pour garantir un sentiment d'appartenance, d'agence et de motivation pour l'action en faveur de la santé mentale liée au climat, en particulier chez les jeunes.

Nous espérons que cet agenda contribuera à concentrer les efforts des communautés de financement, de politique et de pratique qui œuvrent pour un avenir où personne ne sera freiné par les problèmes de santé mentale liés au climat.

Référence rapide : Principaux enseignements

1. L'impact des événements climatiques sur la santé mentale et le bien-être en ALC peut être aggravé par les conditions politiques, culturelles, sociales et économiques.
2. Le risque varie en fonction de la géographie, de la démographie et des caractéristiques socioculturelles. Les peuples autochtones, les minorités ethniques, l'économie côtière et les communautés agricoles, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes souffrant déjà de problèmes de santé mentale ont été perçus comme les plus vulnérables aux perturbations de la santé mentale et du bien-être liées au climat et à l'apparition éventuelle de nouveaux problèmes de santé mentale.
3. Les événements climatiques défavorables peuvent déclencher des événements conduisant à des défis socio-économiques qui ont un impact négatif sur le bien-être mental (par exemple, la sécheresse peut conduire à une perte de sécurité alimentaire, ce qui peut conduire à des migrations forcées et à des déplacements, ce qui peut conduire à des vulnérabilités liées à la pauvreté, ce qui peut conduire à une distorsion du bien-être mental). Il est également possible que des facteurs biologiques, sociaux et psychologiques interdépendants et en cascade, secondaires à l'exposition à des événements climatiques défavorables, exacerbent les problèmes de santé mentale existants. Ces perturbations peuvent être dues à des modifications dans les parcours de soins.
4. Il est tout aussi important d'identifier les sous-groupes de population qui sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale causés par des événements climatiques défavorables et, à l'inverse, ceux qui résistent à ces effets. Il est donc nécessaire de mener des recherches bidirectionnelles. Ce travail nécessitera l'utilisation de méthodes mixtes et devrait chercher à établir des définitions et des critères cliniques pour les conditions de santé mentale liées au changement climatique (par exemple, l'éco-anxiété) et devrait également chercher à valider les outils cliniques existants au sein de l'ALC. Le progrès de la recherche dans la région sera affecté par le manque actuel de systèmes de surveillance de la santé mentale; par conséquent, la recherche devrait inclure des éléments de renforcement des capacités humaines (par exemple, la main-d'œuvre) et infrastructurelles.
5. La sensibilisation et l'adéquation culturelles sont essentielles pour conduire avec succès des recherches sur le climat et la santé mentale en ALC. Les chercheurs doivent savoir que les populations autochtones de l'ALC constituent un groupe diversifié et qu'elles n'ont pas toutes une vision spirituelle du monde.
6. La recherche collaborative (multisectorielle et interdisciplinaire) sera précieuse dans les environnements à ressources limitées de l'ALC.
7. Les partenariats entre les financeurs de la recherche et la société civile en ALC peuvent être utiles où les structures formelles de gouvernance nationale sont fragiles.
8. L'engagement des jeunes en tant que co-créateurs, exécutants et diffuseurs de la recherche est essentiel.
9. Les réponses créées par les communautés peuvent générer des solutions utiles pour faire face aux problèmes de bien-être et de santé mentale liés au changement climatique.
10. La résilience et le sentiment d'appartenance grâce à la défense des intérêts de la communauté, à l'agence et à la motivation sont des co-bénéfices possibles de l'action climatique; les chercheurs devraient étudier des méthodes permettant de suivre et d'évaluer ces co-bénéfices.

Introduction

Contexte

Le changement climatique et la santé mentale sont deux des plus grands défis mondiaux, et la prise de conscience de l'intersection entre la santé mentale et la crise climatique s'est rapidement développée ces dernières années.¹² Le changement climatique exacerbe les problèmes de santé mentale en augmentant l'exposition aux chaleurs extrêmes et aux traumatismes liés aux phénomènes météorologiques extrêmes,¹³ en déstabilisant les conditions nécessaires à une bonne santé mentale et au bien-être (par exemple, l'insécurité hydrique et alimentaire, les migrations forcées, l'air pollué, la perte d'environnements précieux),¹³ en perturbant l'accès aux soins de santé¹⁴, et en augmentant la détresse psychologique en raison de la prise de conscience des menaces climatiques et de l'insuffisance de l'action climatique.¹⁵ Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont également particulièrement vulnérables aux facteurs de stress de la crise climatique, tels que le risque accru de stress physique dû à la chaleur et de décès pendant les vagues de chaleur.^{16, 17, 18}

En réponse à l'impact croissant de la crise climatique sur la santé mentale, la recherche dans le domaine du climat et de la santé mentale s'est développée rapidement. Néanmoins, il existe d'importantes lacunes dans de nombreuses régions, notamment en ce qui concerne la charge de la santé mentale attribuable au changement climatique, les voies et les mécanismes qui sous-tendent ces impacts, les co-bénéfices de l'action climatique pour la santé mentale et les meilleures interventions ou solutions pour soutenir la santé mentale dans un climat changeant. La recherche sur le changement climatique et la santé mentale reste de manière frustrante déconnectée des disciplines, des secteurs et des zones géographiques, et se concentre de manière inégale sur certains sujets et régions du monde.¹⁹ En outre, la prise de décision cloisonnée ralentit la traduction des évidences en actions alignées dans les politiques et les pratiques relatives au climat et à la santé mentale.^{20, 21} Il est urgent de définir un agenda plus inclusif et connecté afin de générer les évidences nécessaires pour véritablement comprendre, surveiller et répondre aux interconnexions entre le changement climatique et la santé mentale.

Connecting Climate Minds

Connecting Climate Minds (CCM) est un projet financé par Wellcome lancé en 2023 pour élaborer un programme inclusif de recherche et d'action en matière de changement climatique et de santé mentale. Le projet a deux objectifs principaux, étroitement liés. Le premier consiste à élaborer un agenda de recherche et d'action aligné et inclusif, fondé sur les nécessités des personnes ayant souffert de problèmes de santé mentale dans le contexte du changement climatique, afin d'orienter les travaux dans ce domaine au cours des prochaines années. Le second consiste à lancer le développement de communautés de pratique connectées pour le changement climatique et la santé mentale dans sept régions du monde (désignées par les Objectifs de Développement Durable), équipées pour mettre en œuvre cet agenda. Nous visons à combiner les forces d'une perspective mondiale et d'une approche régionale, et à rassembler diverses perspectives disciplinaires dans une vision commune qui peut garantir que la recherche est efficace pour combler les lacunes prioritaires et informer les changements dans les politiques et les pratiques à l'intersection du changement climatique et de la santé mentale.

En réunissant des experts de diverses disciplines, secteurs et pays, l'équipe du CCM a facilité l'élaboration d'un agenda de recherche et d'action fondé sur l'expérience vécue pour le domaine du changement climatique et de la santé mentale en Amérique Latine et dans les Caraïbes (ALC).

Objectifs du programme de recherche et d'action

L'agenda de recherche et d'action est conçu pour concentrer les efforts futurs afin d'aider les personnes qui sont ou seront confrontées aux défis de santé mentale liés au changement climatique. Il vise à soutenir ceux qui répondent déjà à ces défis, par l'intermédiaire des communautés, de la recherche, de la politique et de la pratique, en construisant un domaine de changement climatique et de santé mentale plus connecté et plus collaboratif. Il vise également à permettre aux experts de toutes les disciplines et de tous les secteurs de s'habiliter et de progresser dans ce domaine en définissant des priorités claires et en favorisant un champ d'action plus inclusif et transdisciplinaire.

L'agenda répond à ces objectifs par le biais de trois objectifs principaux, qui sont les suivants :

1. Identifier les priorités de la recherche qui peuvent éclairer l'action pour répondre aux besoins des personnes qui subissent les effets du changement climatique sur la santé mentale en Afrique subsaharienne.
2. Identifier ce qui est nécessaire pour mener une recherche appropriée et traduire les évidences en actions dans les politiques et les pratiques en Afrique subsaharienne.
3. Faire comprendre aux chercheurs, aux bailleurs de fonds et aux experts politiques de toutes les disciplines et de tous les secteurs leur rôle dans l'avancement de la recherche sur le changement climatique et la santé mentale, et les équiper avec ces priorités claires et réalisables.

L'agenda régional sera intégré à six autres agendas régionaux afin d'alimenter un **agenda mondial de recherche et d'action** sur le changement climatique et la santé mentale. Cela permettra de garantir que les efforts de recherche et les investissements mondiaux dans le domaine du changement climatique et de la santé mentale s'appuient sur les priorités régionales. Il est important de noter que l'agenda mondial intégrera également des informations provenant d'agendas élaborés avec et pour certains des groupes les plus affectés au niveau mondial, à savoir les peuples autochtones, les jeunes, les petits agriculteurs et pêcheurs.

Utilisation des termes « changement climatique » et « santé mentale »

Le changement climatique, la santé mentale et leur intersection sont des domaines complexes et étendus. Pour les fins de cet agenda, nous définissons ces termes comme suit.

Par **problèmes de santé mentale**, nous entendons des pensées, des sentiments et des comportements qui affectent la capacité d'une personne à fonctionner dans un ou plusieurs domaines de la vie et qui impliquent souvent des niveaux importants de détresse psychologique. Il s'agit notamment de l'anxiété, de la dépression, du stress post-traumatique, de la psychose, des pensées suicidaires et de la toxicomanie.

Par **expérience des effets du changement climatique**, nous entendons : 1) l'impact direct des dangers climatiques, tels que des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, des incendies de forêt, des feux de brousse, des sécheresses, des inondations ou des tempêtes (typhons, ouragans, cyclones), et 2) la perturbation des déterminants sociaux et environnementaux d'une bonne santé mentale, tels que l'obligation de déménager, l'impossibilité d'accéder à la nourriture ou à l'eau, la perte des moyens de subsistance ou des terres d'origine, ou la perturbation des pratiques culturelles en raison du changement climatique.

Les **défis en matière de santé mentale dans le contexte du changement climatique** sont les suivants :

- La façon dont le changement climatique peut entraîner une aggravation des problèmes de santé mentale préexistants.
- Comment le changement climatique peut contribuer à la prévalence ou à l'impact des problèmes de santé mentale existants.
- Comment le changement climatique peut avoir un impact sur l'accès ou l'efficacité des traitements pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
- La façon dont le changement climatique peut entraîner l'apparition de nouveaux problèmes de santé mentale.

Le travail de la CCM offre une occasion unique de mieux comprendre la diversité des perspectives, des cadres et des terminologies en ALC, ce que nous avons également cherché à refléter dans l'agenda de recherche et d'action.

Historique de Connecting Climate Minds

Communauté de pratique régionale

Le projet CCM en ALC est dirigé par une Équipe Communautaire Régionale (ECR), chargée de réunir diverses expertises dans la région et de renforcer les capacités régionales pour créer et mettre en œuvre l'agenda de recherche et d'action. La structure de l'ECR est décrite ci-dessous.

Coordinateur communautaire régional (CCR)

Objet : Responsable de l'élaboration et de l'exécution des activités de projet dans la région, y compris la convocation et le soutien d'une communauté régionale de compétences diverses.

Membres :

Chef d'équipe du projet : **Ambassadrice Gillian Bristol**, Latin American Caribbean Centre (ALC), vice-chancellerie, The UWI Mona, Jamaïque

Chercheur principal/gestionnaire de projet : **Dr Sandeep Maharaj**, Campus UWI St. Augustine,

Conseiller Technique : **Dr Natalie Greaves**, UWI Cave Hill

Chercheur Adjoint : **Dr Shamjeet Singh**, UWI St. Augustine

Chercheur Adjoint : **Dr Satish Jankie**, UWI St. Augustine

Communication/ Administration : **Mme Lina Torres Maestre**

Coordinatrice : **Mme Chandika Ganesh**

Assistante : **Mme Jacinth Seemungal**

Co-coordonateurs

Objet : Apporter une expertise supplémentaire entre les disciplines et les pays (c'est-à-dire les organisations couvrant l'expertise climatique, les neurosciences du stress et l'expertise en santé mentale, dans différents secteurs), fournir des conseils techniques et des examens, et soutenir la réalisation de projets.

Membres :

Professeur Enrique Falceto De Barros, Directeur de WONCA (Organisation Mondiale des Médecins de Famille). Programme de Master en Éducation en Science (PPGECI) à l'Université Fédérale do Rio Grande do Sul (UFRGS)

M. Marcos Williamson, Chercheur en éducation et Directeur du Centre d'Information sur l'Environnement de l' Université des Régions Autonomes de la Côte Caraïbe du Nicaragua (URACCAN), Nicaragua

Dr Martha Rosa Munoz, Directrice de FLACSO Cuba - Faculté Latino-Américaine des Sciences Sociales (FLACSO), Cuba

Dr Fresia Hernandez, Directrice Nationale du Programme de Psychologie Clinique et de la Santé au Tecnológico de Monterrey (TEC), Mexique

Dr Dassaëve Brice, EarthMedic et EarthNurse Haïti

Dr Clemencia Ramirez, Consultante indépendante, Organisation internationale pour les migrations (OMI).

Co-coordonateurs adjoints/facilitateurs du dialogue :

Dr Tatiana Camargo, Centre brésilien de santé planétaire à l'Université de Sao Paulo et à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul.

Dr Raquel Santiago, Santé Planétaire Brésil, IEA/USP

Professeur Jonathan Sherin, The Healthy Brains Global Initiative

Groupe Consultatif sur l'Expérience Vécue (GCEV)

Objet : Comité consultatif d'experts ayant une expérience vécue des problèmes de santé mentale dans le contexte du changement climatique et/ou appartenant à des groupes de population vulnérables et vivant avec des risques climatiques. En s'appuyant sur leur expertise et leur sagesse uniques, les GCEV fournissent des perspectives et des conseils essentiels centrés sur la communauté, qui influencent l'approche globale et les résultats du projet.

Membres :

Mme Vashti Burrows, Bahamas

Mme Gloria Blaise, Haïti

Mme Raquel Tupinamba, Conseil indigène Tupinamba de Baixo Tapajos/Amazonie,

M. Norton Chavarria, Communauté de Karata, Nicaragua

Ambassadeurs de la Jeunesse (AJ)

Objet : Jeunes conseillers (âgés de 18 à 29 ans) ayant une expérience vécue des problèmes de santé mentale dans le contexte du changement climatique et/ou appartenant à des groupes de population vulnérables et vivant avec des risques climatiques. Les AJ apportent des perspectives uniques, centrées sur les jeunes, à l'élaboration et à l'implémentation des activités du projet.

Membres :

Mme Ana Gabriela Mejia - Équateur

M. Harvey Vijay Sharma - Guyane

Méthodologie

- Nous avons élaboré cet programme de recherche et d'action à travers d'une méthodologie solide et inclusive pour capturer, combiner et raffiner une grande diversité de points de vue tout en favorisant les connexions à travers d'une communauté de pratique en croissance. Étant donné la nécessité de générer des données descriptives sur l'expérience vécue à propos d'un sujet relativement nouveau et sensible, une approche pragmatique de méthodes mixtes a été utilisée en s'appuyant fortement sur les principes de la conception de la recherche qualitative.
- L'équipe centrale du CCM a élaboré cette méthodologie en consultation avec les Communautés Régionales de Pratique, un Conseil Consultatif Mondial et Wellcome, ce qui a permis d'apporter d'importantes modifications itératives à la méthodologie. Les méthodes et le matériel ont été adaptés au niveau régional afin d'assurer un équilibre entre la standardisation mondiale et l'adéquation et la flexibilité régionales. Le partage continu des processus, des apprentissages et des défis entre les régions a été essentiel au développement itératif de la méthodologie. Le processus global de développement des agendas régionaux de recherche et d'action est présenté ci-dessous.

Figure 1 : Méthodologie d'élaboration des programmes de recherche et d'action



Exploration pré-dialogue

Le cadrage et l'évaluation globale ont été effectués avant la conduite de la recherche dans les régions des ODD dans le cadre du projet CCM. Lors du cadrage global, l'équipe centrale de la CCM a procédé à :

- Un examen de la portée, au niveau mondial, des études actuelles, des documents clés et des rapports politiques relatifs au changement climatique et à la santé mentale;
- Une identification des catégories de recherche couvertes et utilisées pour structurer les études précédentes dans ce domaine ; et
- Une deuxième identification des recommandations d'action sur le changement climatique et la santé mentale proposées par les rapports rédigés pour informer les politiques et les pratiques.

Ils ont ensuite utilisé ces résultats pour définir la ligne d'enquête pour les dialogues et l'agenda de recherche afin d'assurer l'alignement sur le domaine actuel tout en répondant aux principales lacunes.

Recherche exploratoire menée avec l'ALC

- En outre, le Chef d'Équipe du Projet RCC de l'ALC et le Chercheur Principal se sont engagés avec des experts en expériences vécues et des conseillers spécialisés dans le domaine par le biais de discussions avec des informateurs clés afin de s'assurer que la production du programme de recherche était correctement fondée sur une compréhension des principales nécessités en expériences vécues et des politiques émergentes dans la région.
- Le RCP de ALC a également effectué un examen de portée afin de résumer les évidences liées aux événements/menaces climatiques et aux résultats associés en matière de santé mentale, y compris les mécanismes sous-jacents propres à la région.
- La littérature révisée a identifié des lacunes dans les connaissances et les informations contextuelles concernant le climat et la santé mentale dans la région ALC (ces lacunes sont présentées à l'Annexe 1, tandis que la méthodologie de la révision, les diagrammes PRISMA et le résumé des documents révisés sont présentés à l'Annexe 2).
- L'équipe de ALC a également distribué une **enquête en ligne** avant le Dialogue 1 (**enquête pré-dialogue**) pour solliciter les perceptions sur les impacts climatiques régionaux, les impacts sur la santé mentale liés au climat et les priorités de recherche.
- Les résultats de toutes les activités globales et régionales ont ensuite été combinés pour finaliser la conception de dialogues pertinents au niveau régional et culturellement appropriés.

Méthodologie du dialogue

- Des experts de différentes disciplines et de différents secteurs ont été sélectionnés à dessein et recrutés par effet boule de neige à l'adresse par l'intermédiaire des réseaux régionaux de co-ordinateurs pour participer à deux dialogues virtuels (d'une durée de 3 heures chacun).ⁱ
- Le cadre des dialogues a été conçu par l'équipe mondiale et adapté par le RCoP-ALC afin d'accroître l'adéquation culturelle et la facilité d'utilisation dans les différentes langues et capacités technologiques de la région (voir l'Annexe 3 pour les Programmes de dialogue).
- Les dialogues ont été facilités par une unité de dialogue composée de membres du RCoP-ALC, qui sont eux-mêmes des chercheurs, des décideurs politiques et des experts en expériences vécues, ainsi que des collègues de l'équipe centrale du CCM et du Centre Climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
- Les membres de l'unité de dialogue ont présenté des exposés lors des sessions plénières et ont servi de facilitateurs de discussion, de preneurs de notes ou d'observateurs-chercheurs non participants dans les salles de réunion, contribuant ainsi à la production, à la collecte et à l'analyse des données.
- Le premier dialogue a permis d'identifier les dangers et les risques liés au climat et à la santé mentale, de cartographier les populations vulnérables et de recueillir des informations sur les nécessités régionaux perçus et expérimentés et sur les priorités en matière de recherche.
- Le deuxième dialogue a permis de recueillir des remarques sur les priorités de recherche (issues du Dialogue 1) et d'identifier des réflexions et des recommandations sur la conduite de la recherche et

ⁱ Le principe de la boule de neige consiste à ce que les participants potentiels identifient et recommandent d'autres participants appropriés.

la transposition des évidences en politiques et en pratiques au sein de l'ALC. Il a également exploré la diversité des perspectives régionales et des compréhensions des concepts clés pertinents.

- Les données générées par les dialogues comprennent : Les chats Zoom, les notes prises par des preneurs de notes dédiés, les transcriptions des discussions en salles des petits groupes/ en plénière et les notes Google Jamboard rédigées par les participants (Dialogue 2 uniquement).

Méthodologie de l'enquête

- Nous avons distribué une **enquête en ligne** après le Dialogue 2 afin de vérifier les résultats, d'obtenir un deuxième retour d'information sur les priorités de recherche et d'identifier les méthodes, les mesures et les ensembles de données pertinents pour répondre à ces priorités.

Méthodologie d'analyse

- **Catégories de recherche** : Comme indiqué précédemment, le Climate Cares Centre a procédé à une analyse globale des études existantes sur le changement climatique et la santé mentale et a identifié quatre grandes catégories de recherche comme étant des domaines où il est essentiel de poursuivre les travaux à l'échelle mondiale. Ce cadre a été utilisé comme base pour structurer les discussions au sein des dialogues afin de générer des priorités de recherche et a constitué le cadre de codage global pour l'analyse.
- **Générer des thèmes de recherche prioritaires** : Les participants au Dialogue 1 ont été guidés dans une discussion semi-structurée explorant leurs points de vue sur les conséquences émergentes et probables sur la santé mentale liées aux dangers climatiques actuels et futurs au niveau régional, ainsi que sur les possibilités d'actions bénéfiques pour la santé mentale. Les participants ont ensuite conceptualisé des thèmes de recherche possibles en se basant sur les domaines dans lesquels les évidences pourraient utilement informer/impacter les politiques et les pratiques (voir l'Annexe 4 pour les critères de sélection des thèmes de recherche prioritaires).
- **Analyse** : Les données du dialogue (transcriptions des séances de discussion et notes) ont été analysées à l'aide d'une méthode hybride de cadre thématique - une approche basée sur une matrice qui permet aux chercheurs qualitatifs d'entreprendre une interrogation approfondie des données (par exemple, les transcriptions et les notes écrites) afin de faciliter l'identification de schémas récurrents dans les données.
 - L'équipe d'analystes (voir l'Annexe 5 pour la description) a utilisé un cadre de codage pour coder les transcriptions des dialogues (voir l'Annexe 6).
 - Des résumés nuancés des modèles identifiés ont ensuite été produits en fonction des quatre grandes catégories identifiées lors de l'exercice global et résumés dans un tableau matriciel.
 - Des citations clés tirées des notes et des transcriptions des discussions sont présentées plus loin dans ce rapport comme évidence contextuel à l'appui des thèmes.
- **Rédiger de thèmes de recherche prioritaires** : Les résumés nuancés mentionnés ci-dessus ont été utilisés pour dresser une liste des thèmes de recherche prioritaires sur la base d'une triangulation entre les notes des groupes de discussion, les transcriptions, l'évaluation de la portée du pré-dialogue et la consultation d'experts.
- **Affiner les thèmes de recherche prioritaires** : Les thèmes de recherche (sous forme de questions) ont été communiqués aux participants du Dialogue 2, qui ont donné leur avis en réponse aux questions suivantes:

« S'agit-il d'un sujet de recherche important pour l'ALC ? Faut-il y ajouter ou en retrancher quelque chose ? » (Les questions ont été présentées en langage simple pour faciliter l'accès à tous les participants). Les thèmes de recherche ont ensuite été affinés en fonction de ce retour d'information et transmis aux participants au dialogue pour qu'ils puissent commenter dans une enquête postérieure au dialogue, ce qui constitue une forme de contrôle des participants. Dans l'introduction de l'enquête, les participants ont été remerciés (ce qui est culturellement nécessaire), puis invités à apporter les changements nécessaires. L'enquête post-dialogue a également été diffusée à un échantillon plus large d'experts qui n'avaient pas participé au dialogue, avec la question: *Souhaitez-vous modifier, supprimer ou ajouter quelque chose à ce thème de recherche ?* Tous les participants à l'enquête post-dialogue ont eu la possibilité de suggérer des thèmes de recherche additionnels.

- **Finalisation des thèmes de recherche prioritaires** : La liste finale des thèmes de recherche prioritaires a été établie en tenant compte de retour d'information sur l'enquête, de la consultation du RCoP-ALC, des experts régionaux, de l'équipe centrale de CCM, du Conseil Consultatif Mondial et de Wellcome.

Participants

Les participants au dialogue formaient un groupe diversifié en termes de répartition géographique, de genre, de secteur et de discipline. Tous les participants ont été invités aux deux dialogues, mais dans certains cas, ils n'ont pas pu y assister.

Au total, 45 participants ont assisté au Dialogue 1 et 30 au Dialogue 2. Les tableaux ci-dessous présentent une ventilation des caractéristiques des participants.

Répartition géographique

Pays	Dialogue 1		Dialogue 2	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Bahamas	1	2,5 %	1	3,80 %
Barbade	1	2,5 %	1	3,80 %
Bolivie (État plurinational de)	1	2,5 %	0	0 %
Brésil	4	11 %	5	19 %
Chili	2	5 %	0	0 %
Costa Rica	1	2,5 %	1	3,80 %
Équateur	1	2,5 %	0	0 %
Grenade	2	5 %	0	0 %

Guatemala	1	2,5 %	1	3,80 %
Haïti	4	11 %	5	19 %
Honduras	3	8 %	0	0 %
Jamaïque	3	8 %	2	8 %
Mexique	3	8 %	1	3,80 %
Nicaragua	3	8 %	2	8 %
Sainte-Lucie	1	2,5 %	0	0 %
Trinité-et-Tobago	5	13 %	7	27 %
États-Unis d'Amérique	2	5 %	0	0 %

Expertise

	Dialogue 1		Dialogue 2	
Expertise	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Changement climatique	12	21 %	7	19 %
Santé mentale	13	23 %	11	29,7 %
Santé	18	31,5 %	14	37,8 %
Autre	14	24,5 %	5	13,5 %
Je ne sais pas / Je préfère ne pas me prononcer	0	0 %	0	0 %

Discipline

	Dialogue 1		Dialogue 2	
Discipline	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Activisme	5	4,5 %	4	5 %
Communauté	13	12 %	9	11 %
Éducation	21	19 %	17	21 %

Expert à travers ma propre expérience vécue	5	4,5 %	4	5 %
Financement	1	1 %	0	0 %
Soins de santé	16	14,5 %	12	15 %
Organisation non gouvernementale	13	12 %	9	11 %
Politique	4	3,5 %	4	5 %
Recherche	25	23 %	19	24 %
Autre	7	6 %	2	3 %

Genre

	Dialogue 1		Dialogue 2	
Sexe	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Hommes	8	36 %	12	46 %
Femmes	13	59 %	14	54 %
Non-binaire	1	5 %	0	0 %
Je ne sais pas / Je préfère ne pas me prononcer	8	36 %	12	46 %

Participants à l'enquête :ⁱⁱ

Enquête préalable au dialogue : 76

Enquête post-dialogue : 6

Éthique, collecte et stockage des données

Cette étude a été revue et a reçu un avis favorable du Comité d'Éthique de Recherche de l'Imperial College (titre de l'étude: « Global Dialogues to set an actionable research agenda and build a community of practice in climate change and mental health (Dialogues mondiaux pour établir un programme de recherche exploitable et créer une communauté de pratique sur le changement climatique et la santé

ⁱⁱ Veuillez noter que les chiffres sont approximatifs et ne tiennent pas compte des réponses doubles ou incomplètes.

mentale) », numéro d'identification de l'étude : 6522690). En outre, le protocole de l'étude, avec les adaptations locales nécessaires, a été revue et approuvé par le Conseil de Révision Institutionnel de l'Université des Indes Occidentales, St Augustine [CREC-SA. 2298/08/2023].

Les détails sur la collecte et le stockage des données figurent à l'annexe 7.

État actuel et besoins émergents en matière de changement climatique et de santé mentale en Amérique latine et dans les Caraïbes

Alors que la crise climatique s'aggrave, de plus en plus de personnes dans le monde subissent des conséquences connexes sur leur santé mentale. Cependant, la base de données actuelle ne rend pas pleinement compte de ces expériences. Pour développer des thèmes de recherche qui répondent en fin de compte aux besoins de ceux qui vivent et réagissent aux interconnexions entre le changement climatique et la santé mentale, il est essentiel de savoir: 1) Quelles sont les expériences, les nécessités et les capacités de résistance rapportés par des personnes issues de milieux, de contextes et de secteurs différents - en particulier celles qui ont souffert des problèmes de santé mentale dans le contexte de la crise climatique - et 2) De quelles évidences les personnes qui prennent des décisions et des mesures sur le terrain ont-elles besoin pour réagir de manière adéquate?

Cette section présente le contexte d'agenda de recherche, en explorant les dangers climatiques auxquels la région est confrontée, l'état actuel des évidences sur la santé mentale et le changement climatique dans la région ALC, ainsi que les principaux points de vue et les nécessités émergents de la région.

Dangers climatiques en ALCⁱⁱⁱ

L'Amérique latine et les Caraïbes (ALC) sont confrontées à une augmentation de la fréquence et de la gravité d'une série de dangers climatiques, dont les suivants, modélisés jusqu'à environ 2030 par rapport à la référence historique (généralement 1986-2005) : ^{22, 23, iv}

- **Températures extrêmes**, en particulier dans les régions tropicales d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et de Cuba, ainsi que dans les régions côtières du Mexique (avec des variations d'un modèle climatique à l'autre ; confiance moyenne) ; ^v
- **Sécheresses et incendies de forêt** dans le nord de l'Argentine, dans les régions les plus peuplées du Brésil et dans certaines zones du Mexique (degré de confiance élevé) ;

ⁱⁱⁱ Informations basées sur l'exercice de mappage et les projections du Centre Climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (méthodes détaillées à l'Annexe 8).

^{iv} Les projections futures sont basées sur le scénario d'émissions du milieu de la route (SSP2-4.5 Shared Socio-economic Pathway) de l'ensemble multi-modèle CMIP6 fourni dans le GIEC, 2021.

^v Dans le cadre du GIEC et d'autres sources importantes de projections climatiques, les niveaux de confiance sont indiqués sur une échelle de faible, moyen, élevé. Le classement se réfère à la robustesse des preuves disponibles et à la concordance entre les modèles climatiques.

- **Fortes précipitations et inondations** : l'intensité et la fréquence des précipitations extrêmes et des inondations pluviales devraient augmenter en Amérique du Sud (degré de confiance moyen à élevé), bien que l'Amérique Centrale et les Îles des Caraïbes soient plus susceptibles de connaître une baisse des précipitations moyennes (degré de confiance faible) ;
- **L'élévation du niveau de la mer**, qui contribue à l'augmentation des inondations côtières dans les zones de faible altitude et au recul du littoral de la plupart des côtes sablonneuses, en particulier autour de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud (degré de confiance élevé) ; et
- **les cyclones tropicaux**, avec une augmentation médiane prévue d'environ 3 %.

Changement climatique et santé mentale en Amérique latine et dans les Caraïbes : Résumé de l'examen de la portée

Un examen de la portée réalisé dans le cadre de l'étape fondamentale de ce projet a révélé un nombre limité d'études dans la région ALC portant sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale. Les recherches existantes fournissent des informations importantes fondées sur les contextes culturels et historiques du climat et de la santé mentale en Amérique latine et dans les Caraïbes²⁻¹¹ Cependant, de nombreuses études ont été menées après des catastrophes cycloniques majeures et ne prennent pas en compte l'impact de la crise climatique sur la santé mentale de manière plus large. La littérature identifiée se concentre principalement sur les effets négatifs sur la santé mentale dus aux événements climatiques extrêmes aigus dans le contexte a) de la gravité du trauma/de la perte dont on a été témoin/expérimenté et b) des vulnérabilités socio-économiques sous-jacentes.^{2,3,4} Par conséquent, il est nécessaire d'établir un agenda de recherche et d'action qui explore l'ensemble du spectre des événements climatiques aigus et rampants ayant un impact sur la région. L'influence positive des espaces verts mérite également une attention particulière.⁸

L'étude exploratoire a suggéré qu'un agenda d'action de recherche pour l'ALC devrait être discuté et étudié de concert avec les schémas de migration et d'autres facteurs sociopolitiques et économiques susceptibles d'influencer ou de médier la relation entre le changement climatique et la santé mentale.

Synthèse des résultats des dialogues et des enquêtes

Cette sous-section présente les résultats des dialogues et des enquêtes décrits précédemment concernant les perceptions de quatre catégories de recherche primordiales, énumérées ci-dessous. Ces catégories ont été identifiées comme des domaines où il est essentiel de poursuivre les travaux à l'échelle mondiale et qui cartographient l'espace de recherche sur le climat et la santé mentale à un niveau élevé, sur la base d'un premier examen de la littérature. Les thèmes de recherche prioritaires de la section suivante sont également classés dans ces quatre catégories.

- **Impacts, risques et groupes vulnérables** : mieux comprendre dans quelle mesure la santé mentale est affectée par le changement climatique et pour qui. Par exemple : quels résultats en matière de santé mentale sont affectés ou menacés ; la prévalence, la gravité, les coûts économiques et sociétaux de ces impacts ; et qui est le plus vulnérable à ces impacts.
- **Voies et mécanismes** : améliorer notre compréhension de la manière dont le changement climatique affecte la santé mentale et, en particulier, déterminer s'il existe des facteurs spécifiques au changement climatique qui augmentent les risques pour la santé mentale ou créent de nouvelles expériences de problèmes de santé mentale. Cela implique de prendre en compte les voies et les mécanismes biologiques, psychologiques, sociétaux ou environnementaux.

- **Bénéfices pour la santé mentale de l'action climatique (adaptation et atténuation du changement climatique) :** comprendre et quantifier quand et comment les mesures d'adaptation et d'atténuation climatiques, dans tous les secteurs, peuvent également avoir des bénéfices gagnants-gagnants pour la santé mentale.
- **Interventions/solutions en matière de santé mentale dans le contexte du changement climatique :** identification des interventions/solutions les plus efficaces pour soutenir la santé mentale dans le contexte du changement climatique, dans divers secteurs. Cela implique d'apporter un soutien aux personnes qui subissent déjà des effets négatifs sur leur santé mentale et de réduire le risque ou la gravité des effets négatifs à venir.

Tableau 2 : Résultats de la recherche sur les besoins régionaux émergents en matière de santé mentale dans le contexte du changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes .

Catégorie de recherche	Synthèse générale des résultats pour la région Amérique latine et Caraïbes
Impacts, risques et groupes vulnérables	Risques variés et vulnérabilités diverses : Dans la région Amérique latine et Caraïbes, le risque de problèmes de santé mentale liés au climat varie selon les zones géographiques, les caractéristiques démographiques personnelles et les caractéristiques socioculturelles. Les groupes suivants ont été identifiés comme étant les plus vulnérables aux perturbations du bien-être mental liées au climat et à l'apparition possible de nouveaux problèmes de santé mentale : • Les enfants • L'économie côtière et les communautés rurales • Les personnes handicapées • Les minorités ethniques • Les groupes autochtones • Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale préexistants • Femmes • Les jeunes Il est tout aussi important d'identifier les sous-groupes de population qui sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale causés par des événements climatiques défavorables et, à l'inverse, ceux qui sont résilients à ces effets. Par conséquent, il est nécessaire de mener des recherches bidirectionnelles explorant la double perspective de la vulnérabilité et de la résilience climatique. <i>Un concept de raffinage important :</i> Les peuples autochtones doivent être considérés comme des groupes hétérogènes. Ne présumons pas que tous les groupes autochtones ont un lien spirituel. Commentaires sur la méthodologie, les mesures et les données existantes : Les méthodes de recherche doivent tenter de définir le problème de santé mentale « supplémentaire » associé au changement climatique. Dans certaines régions de la zone Amérique latine et Caraïbes, il

Voies et mécanismes	n'existe pas de données sur la charge de morbidité mentale non liée au climat , des études de prévalence peuvent donc être nécessaires, ainsi que des systèmes de surveillance, de suivi et d'évaluation pour établir des bases de référence et suivre les tendances. Des voies biologiques, sociales et économiques complexes et reliées entre elles : Les événements climatiques défavorables peuvent servir de déclencheurs primaires à une cascade d'événements conduisant à des résultats socio-économiques défavorables qui peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être mental (par exemple, la sécheresse peut entraîner une perte de sécurité alimentaire, qui peut conduire à des migrations forcées et à des déplacements, qui peuvent entraîner des vulnérabilités liées à la pauvreté, qui peuvent conduire à une distorsion du bien-être mental). Il est également possible que des facteurs biologiques, sociaux et psychologiques interdépendants et en cascade, secondaires à l'exposition à des événements climatiques défavorables, exacerbent les problèmes de santé mentale existants. Ces distorsions peuvent être dues à des modifications dans les parcours de soins. Concepts importants en matière de raffinage : Étant donné que les facteurs au sein de l'ALC se produisent simultanément et agissent potentiellement en synergie, tout programme de recherche devra être interdisciplinaire et orienté vers l'action, en identifiant et en traitant simultanément les mécanismes par lesquels la crise climatique a un impact sur le bien-être mental, soit en créant ou en aggravant les défis en matière de santé mentale.
Avantages de l'action climatique (adaptation et atténuation du changement climatique) pour la santé mentale	Utilisation des structures existantes et implication dans la défense des intérêts : Il peut être avantageux d'utiliser les mécanismes existants de réaction aux catastrophes du climat pour favoriser ou préserver la santé mentale et le bien-être mental en présence de menaces du climat. Ces mécanismes de réponse ont été décrits comme étant multisectoriels, bien établis et présents aux niveaux local, national et régional. En outre, le fait d'agir et d'espérer grâce à la défense des droits a été identifié comme un avantage possible de l'action climatique pour la santé mentale ; des travaux supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne la défense des droits et l'action des jeunes.
Interventions en matière de santé mentale dans le contexte du changement climatique	Une action collective est nécessaire : Les réponses communautaires, y compris celles des groupes religieux et de ceux qui croient en une puissance qui dépasse l'humanité, peuvent être des outils utiles pour faire face aux problèmes de bien-être et de santé mentale qui découlent du changement climatique. Un partenariat multi-système est également nécessaire pour traiter les facteurs sociaux, économiques et commerciaux combinés de ces défis. Les participants au dialogue ont également proposé plusieurs idées sur la manière dont les soins de santé mentale pourraient être renforcés, notamment en veillant à ce que les prestataires de soins de santé offrent des services contextualisés et adaptés à l'impact du climat.

Concepts importants en matière de raffinage : Le renforcement de l'offre de soins de santé mentale et la déconsidération des problèmes de santé mentale sont des questions fondamentales en Amérique latine et dans les Caraïbes. La recherche sociale, comportementale et organisationnelle qui prend en compte le climat et la santé mentale est essentielle.

Agenda de recherche

Thèmes de recherche prioritaires

Contexte des catégories de recherche et des thèmes de recherche prioritaires

Ce programme de recherche présente une vision harmonisée pour guider le domaine du climat et de la santé mentale en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les priorités de recherche ont été définies à l'issue d'une vaste consultation d'experts de toutes les disciplines, de tous les secteurs et de toutes les zones géographiques de la région et ont fait l'objet d'une itération avec des experts régionaux et internationaux. Les thèmes de recherche prioritaires représentent des domaines dans lesquels un investissement ciblé dans la recherche pourrait permettre de dresser un tableau complet des incidences du climat sur les problèmes de santé mentale, de leurs mécanismes et de leurs solutions, tant au niveau de la santé mentale que des actions climatiques.

Nous espérons que ces questions serviront d'inspiration pour guider l'orientation de la communauté de pratique de la recherche, fournir des objectifs d'investissement pour les bailleurs de fonds et concentrer la production de preuves pour permettre aux décideurs politiques et aux praticiens de répondre au mieux aux besoins de santé mentale liés au changement climatique dans la région ALC.

Tableau 3 : Thèmes de recherche prioritaires

Catégorie de recherche	Thème de recherche prioritaire
1. Impacts, risques et groupes vulnérables	- Identifier les caractéristiques des personnes vivant dans des populations vulnérables au changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes et mesurer comment la santé mentale de ces populations est affectée par ces vulnérabilités. - Comprendre comment les populations vulnérables au climat en Amérique latine et dans les Caraïbes perçoivent les événements climatiques extrêmes et y réagissent, et comment ces perceptions et réactions sont liées aux résultats en matière de santé mentale. (Ceci est important pour les populations qui pourraient ne pas considérer le changement climatique comme négatif, telles que les personnes ayant une vision spirituelle du monde qui perçoivent le changement climatique comme normal ou attendu.) - Étudier le lien éventuel entre l'exposition à des événements climatiques défavorables et l'apparition de problèmes de santé mentale ou de

changements dans l'état de bien-être mental de base d'une personne en Amérique latine et dans les Caraïbes.

- Quantifier les problèmes de santé mentale et de bien-être mental directement imputables au changement climatique parmi [insérer la population concernée, comme les groupes vulnérables identifiés, par exemple les communautés de pêcheurs] en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Mesurer l'incidence et la prévalence des changements dans [indiquer un problème de santé mentale spécifique, par exemple les idées suicidaires] ou le bien-être mental de base d'une personne attribuables au changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Identifier les événements du climat associés au risque le plus élevé d'aggravation des problèmes de santé mentale et/ou de mauvais bien-être mental au sein de la population de la région ALC.
- Identifier les facteurs sociodémographiques qui influencent la vulnérabilité aux problèmes de santé mentale liés au changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Identifier et comprendre quels facteurs de l'expérience vécue, secondaires aux événements liés au climat dans la région ALC, augmentent la probabilité de problèmes de santé mentale.
(Si elle est étudiée sous un angle qualitatif, cette question peut être élargie pour évaluer l'impact du témoignage et de la réponse à un traumatisme climatique aigu, à une perte ou à un deuil lié à l'écosystème, à une violence sexuelle découlant des effets du changement climatique et à une marginalisation/stigmatisation/discrimination liée à la pauvreté et secondaire au changement climatique, comme cela a été identifié dans les dialogues.)
- Identifier et évaluer les moyens les plus efficaces de recruter et d'échantillonner des populations vulnérables au climat dans de vastes zones géographiques de l'Amérique latine et des Caraïbes, afin de faciliter la collecte de données appropriées et solides dans le cadre de la recherche sur le climat et la santé mentale.
- Identifier et évaluer des méthodes culturellement appropriées et rentables pour recueillir des données sur l'expérience vécue, orientées vers la recherche de solutions, concernant la santé mentale liée au climat chez les [insérer la population concernée, par exemple les peuples autochtones] touchés par [insérer l'événement climatique, par exemple la sécheresse] en Amérique latine et dans les Caraïbes.

2. Voies et mécanismes

- Mesurer la prévalence de la violence fondée sur le genre chez les femmes et les enfants marginalisés par le climat (y compris les personnes sans abri, les migrants ou les personnes dont le logement est précaire en raison d'événements climatiques) en Amérique latine et dans les Caraïbes et la manière dont cette violence affecte la santé mentale et le bien-être mental.
- Évaluer l'impact de la chaleur sur la biodisponibilité des médicaments utilisés pour traiter les troubles mentaux dans la région ALC et la stabilité

de ces médicaments pendant le stockage.

(En particulier, cette question explore l'impact de la chaleur sur les composants actifs des médicaments et la manière dont ces composants interagissent ensuite avec les mécanismes physiologiques.)

- Évaluation de l'impact des mécanismes biologiques modifiant le cortisol sur les problèmes de santé mentale et le bien-être mental des personnes touchées par des événements du climat défavorables en Amérique latine et dans les Caraïbes. *(Les participants ont spécifiquement mentionné l'effet du stress lié au climat sur les niveaux de cortisol ; les effets sur d'autres hormones liées au stress pourraient également faire l'objet de recherches.)*
- Analyser l'impact de [insérer tout événement du climat] sur le rythme circadien de [insérer toute population] en ALC et les effets qui en résultent sur les résultats en matière de santé mentale. *(Le rythme circadien fait référence aux cycles physiologiques de sommeil et d'éveil. Cette question explore les effets sur la santé mentale des perturbations qui peuvent survenir dans les hormones associées en raison des changements de ce rythme dus à des facteurs climatiques tels que la chaleur ou le déplacement d'un logement ou abri à la suite d'une catastrophe climatique, etc.)*

3. Avantages de l'action climatique (adaptation et atténuation du changement climatique) pour la santé mentale

- Identifier les interventions les plus efficaces pour encourager l'action communautaire collective en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation du changement climatique, de manière à améliorer également les résultats en matière de santé mentale (par exemple, l'action collective autour de la réponse aux catastrophes, l'action collective pour améliorer les espaces verts et les projets de plantation d'arbres) en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Identifier et évaluer les interventions les plus efficaces pour promouvoir le plaidoyer et l'agence en tant qu'outil pour favoriser la résilience climatique chez les jeunes de l'ALC et évaluer les implications de ces interventions sur les résultats en matière de santé mentale.
- Identifier les obstacles à la sensibilisation à l'impact du climat sur la santé mentale parmi les populations vulnérables au climat en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Identifier et évaluer des activités d'éducation ou de sensibilisation au changement climatique culturellement appropriées, accessibles et abordables, susceptibles d'améliorer les résultats en matière de santé mentale pour les populations vulnérables au climat en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Identifier des mécanismes peu coûteux pour partager efficacement des informations sur les risques du climat avec les populations vulnérables (y compris dans le cadre de l'éducation formelle et informelle) en Amérique latine et dans les Caraïbes et évaluer l'impact de ces informations sur les résultats en matière de santé mentale.

(Cette recherche devrait inclure l'identification et l'évaluation des structures existantes d'échange d'informations dans les domaines de la santé mentale ou du climat, par exemple en s'appuyant sur les systèmes d'alerte d'urgence en cas de catastrophe.)

- Évaluer le potentiel de modification des stratégies existantes de communication sur les risques de catastrophes (qui sont utilisées pour aider à minimiser les effets sur la santé mentale des catastrophes climatiques dans les régions vulnérables au climat) afin de traiter les effets sur la santé mentale des menaces climatiques rampantes et aiguës dans les régions d'Amérique latine et des Caraïbes.
- Identifier et évaluer les mécanismes de survie à la sécheresse et/ou de gestion de l'utilisation des terres utilisés par les populations autochtones en Amérique latine et dans les Caraïbes et leur potentiel pour minimiser la détresse mentale et améliorer les résultats en matière de santé mentale pour les populations touchées par le changement climatique. *(L'événement climatique peut être modifié pour cette question.)*

4.
Interventions/solutions en santé mentale dans le contexte du changement climatique

- Évaluer l'impact des pratiques quotidiennes de pleine conscience ou spirituelles sur les problèmes de santé mentale et le bien-être mental parmi les [insérer une sous-population, par exemple, Calinago] en Amérique latine et dans les Caraïbes en réponse à [insérer l'événement climatique d'intérêt].
- Identifier et évaluer l'efficacité des plantes médicinales et des graines créoles utilisées par les populations autochtones pour minimiser ou réduire les problèmes de santé mentale causés par le changement climatique dans [insérer une région spécifique] et comprendre les implications d'un climat changeant pour leur utilisation et leur disponibilité.
- Identifier les moyens les plus efficaces pour une action interdisciplinaire et multisectorielle afin de soutenir les interventions en matière de climat et de santé mentale en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Identifier et évaluer les politiques et les mécanismes de financement partagés (entre le climat et la santé mentale) dans la région pour soutenir la recherche à l'intersection de la santé mentale et du climat en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Comprendre a) comment les personnes souffrant de problèmes de santé mentale se connectent aux services de soins en ALC, b) si cela change dans le contexte des crises liées au climat, c) si cela change, comment les résultats sont affectés et d) la meilleure façon de fournir des soins appropriés et continus.
- Identifier et évaluer les interventions collectives et communautaires les plus bénéfiques pour protéger la santé mentale et le bien-être mental

dans le contexte de la crise climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes.

- Comprendre le rôle de la religion et de la spiritualité (confiance dans l'existentiel) dans la contextualisation et l'expérience des défis de santé mentale liés au changement climatique en ALC et comment en tenir compte de manière appropriée dans l'élaboration et la mise en œuvre des interventions.
- Identifier les partenariats multi-systèmes les plus efficaces pour traiter les déterminants sociaux, économiques et commerciaux combinés des problèmes de santé mentale et/ou du mauvais bien-être mental qui peuvent s'aggraver en raison des menaces du climat aiguës et chroniques.
(Cette question est incluse pour souligner la nécessité d'une action multisectorielle et systémique pour étudier et traiter l'impact de la crise climatique sur la santé mentale.)
- Comprendre la nature et l'efficacité des pratiques d'autogestion et de résilience des populations autochtones en ce qui concerne [insérer l'événement indésirable] et [insérer le résultat intéressant en matière de santé mentale].

Programme d'action

À mesure que le domaine du changement climatique et de la santé mentale en Amérique latine et dans les Caraïbes se développe et que la base de données s'étoffe, il sera essentiel d'éviter de maintenir les défis existants, notamment : 1) les déconnexions entre les disciplines et entre les chercheurs et les décideurs politiques ; 2) la focalisation inégale sur les sujets et les géographies ; et 3) la prise de décision cloisonnée pour le climat et la santé mentale. Ce calendrier d'action définit une vision commune qui servira de point de ralliement au domaine de la santé mentale et du changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cela comprend des conseils sur la meilleure façon de soutenir la communauté croissante de praticiens, la façon de convertir des données probantes en actions et les principes qui devraient guider cette approche. La mise en œuvre de ce programme exigera un effort transdisciplinaire et une action coordonnée à l'échelle de la recherche, du financement de la recherche, de la politique et des pratiques médicales. Le présent calendrier d'action vise à faciliter ce travail en définissant les défis à relever, les opportunités à exploiter et les actions prioritaires à mener pour parvenir à un domaine prospère en matière de climat et de santé mentale.

Vision régionale de la santé mentale dans un climat en mutation

Déclaration de vision

Sur la base de l'exercice de visualisation et des conversations des dialogues 1 et 2, les participants ont exprimé leur espoir en un avenir où ***, grâce à des actions correctives collectives, les impacts humains sur le changement climatique seront inversés ou minimisés. Les résultats en matière de santé mentale liée au climat sont améliorés par la réduction des risques du climat et la création d'une infrastructure politique et sociale favorable, qui comprend la recherche interdisciplinaire participative et de meilleurs services de diagnostic et de traitement pour les problèmes de santé mentale liés au climat.***

- L'état souhaité de la santé mentale liée au climat est un état dans lequel :
 1. Les mesures politiques visant à protéger la santé mentale de la population contre les menaces du climat sont mises en œuvre sur la base de données probantes produites par une communauté régionale de chercheurs interdisciplinaires qui travaillent en collaboration avec tous les secteurs de la société (y compris les personnes ayant une expérience vécue) ;
 2. Les termes clés (par exemple l'éco-anxiété) sont clairement définis dans le contexte de l'ALC ;
 3. Les critères de diagnostic des effets du climat sur la santé mentale sont clairement établis ;
 4. Des instruments ou outils psychométriques validés sont en place pour la région ;
 5. Il existe des voies d'accès adaptées pour orienter les personnes vers les soins de santé mentale appropriés en réponse aux menaces climatiques aiguës et chroniques ; et

6. La fourniture de soins de santé mentale dans le contexte du changement climatique va de pair avec la réforme du système de santé mentale et la déstigmatisation du concept de santé mentale dans la région.

Créer un environnement favorable à la recherche à l'intersection du changement climatique et de la santé mentale

Les priorités de recherche identifiées n'auront de valeur que si elles sont mises en œuvre. Le domaine du climat et de la santé mentale, relativement nouveau, connaît une croissance rapide, et le moment est venu de veiller à ce qu'il soit conçu pour permettre dans le futur une meilleure santé mentale dans le contexte de la crise climatique. Il est nécessaire d'identifier et de décrire les éléments essentiels au soutien des efforts de renforcement des capacités dans un domaine qui couvre de multiples disciplines et secteurs, chacun ayant des cultures et des méthodes de travail différentes, ceci sur un sujet peu connu dans de nombreux pays. Quels principes doivent s'appliquer dans ce domaine, et quels sont les défis et les opportunités dans la région pour créer un environnement qui permettrait cette recherche ?

Cette section présente une synthèse des discussions sur les éléments nécessaires à la mise en œuvre de l'agenda de recherche et à la création d'un environnement de recherche favorable au changement climatique et à la santé mentale. Ces données sont présentées avec des citations à l'appui dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Créer un environnement favorable à la recherche dans l'intersection du changement climatique et de la santé mentale

Conceptualité	Résumé	Citations de soutien exprimées par les participants*
État souhaité	Il est fondamental de disséquer l'impact du changement climatique sur la santé mentale, notamment en définissant la vulnérabilité, le concept d'« impact » et la relation avec des contextes sociaux plus larges. La recherche devrait définir les états de santé mentale liés au climat, en particulier ceux qui peuvent présenter des facteurs aggravants, en poursuivant le développement ou la validation d'outils de diagnostic. Enfin, il est nécessaire de mener des recherches qui permettent d'apporter des éclairages sur l'organisation et la fourniture de services de santé mentale durables liés à la crise climatique ou déclenchés par elle. Cela nécessitera des approches participatives de la recherche basées sur la communauté.	« Je considère donc que cette recherche permettra de mieux comprendre la dynamique spatiale de la santé mentale dans le contexte du changement climatique. En d'autres termes, je pense que nous supposons qu'il existe une différence dans l'environnement de la santé mentale pendant les crises climatiques dans d'autres espaces. Cela semble être une hypothèse. » - Séance de travail en petits groupes en anglais 1, Dialogue 2 « En réalité, la santé mentale est assez sale. Il est très difficile de nettoyer. Par exemple, l'éco-anxiété... Je pense que la création et la validation d'instruments est une chose, je pense que le diagnostic institutionnel... La chose la plus difficile, je pense, est le diagnostic de l'éco-anxiété qui, je le sais, a de l'ampleur, mais qui n'est pas non plus validé. Vous devez valider. C'est très tôt. » - Séance de travail en petits groupes en portugais, Dialogue 2

		« Nous avons besoin de chercheurs universitaires, d'épidémiologistes et de spécialistes des sciences sociales pour examiner l'impact social, ainsi que les déterminants cliniques ou sociaux de la santé. » - Séance de travail en petits groupes en anglais 2, Dialogue 2
Défis	• Absence de consensus sur les termes clés • Absence de validation des outils • Absence ou utilité limitée des systèmes de surveillance ou des registres pour les données relatives à la santé mentale • Manque possible de compréhension de la présentation des manifestations retardées de la santé mentale après la catastrophe, entraînant des diagnostics tardifs • Financement	: « Je pense que l'une des choses que nous ne détectons pas vraiment, c'est le syndrome de stress post-traumatique, qui survient longtemps après. » - Séance de travail en petits groupes 2 en anglais, Dialogue 2 « Comment les symptômes évoluent-ils ? Comment se présentent-ils au moment de la catastrophe, après un certain temps et après un temps plus long ? » - Enquête post-dialogue, région du Brésil « Je sais que les données sur le suicide sont difficiles à mesurer. Et si vous essayez d'avoir un impact sur la santé mentale ou... Nous ne disposons pas d'un très bon réseau ni de soins de santé mentale. Alors, comment mesurer et être en mesure de faire ce chevauchement ? » - Séance de travail en petits groupes, Dialogue 2 « Les agences de financement pourraient s'intéresser à ce sujet, car tout ce qui est dit sur le changement climatique est à très long terme, mais très axé sur les questions environnementales de sauvetage de la biodiversité, de relecture des processus de production alimentaire... de souveraineté et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui a un impact direct, à mon avis, sur la santé mentale » - Séance de travail en petits groupes, Dialogue 2 « Former les prestataires de soins de santé à notifier la classification internationale des maladies (CIM-11) liée au changement climatique. Par exemple, l'insomnie due à une vague de chaleur : notifier les deux CIM G47 » - Enquête post-dialogue, région du Brésil

Opportunités et catalyseurs	• Partenariat avec des institutions existantes, telles que l'université de Sao Paulo ou l'université fédérale de Rio Grande do Sul, afin de concevoir et d'exécuter des recherches dans des cadres universitaires et non universitaires Tirer parti des travaux actuellement commandés par de grands groupes internationaux dans des domaines connexes, tels que la sécurité alimentaire, dans la région	« Nous avons les étudiants, nous avons les universités, dans ce cas, nous sommes tous issus du monde universitaire, nous avons un système de santé. Nous avons déjà la structure. Je pense qu'il s'agit d'une opportunité, d'un catalyseur » - Séance de travail en petits groupes en portugais, Dialogue 2 « Je voulais vraiment utiliser les étudiants, parce que les étudiants, lorsque nous avons donné le cours, sont venus avec beaucoup d'anxiété écologique, avec beaucoup de... Une jeune fille a même déclaré : « Je veux quitter l'école de médecine parce que je vais faire vivre les gens plus longtemps et que la planète va souffrir. Je pense donc que je vais arrêter la médecine. » Ils en parlent beaucoup. Je pensais plutôt à faire des recherches sur eux ou sur les communautés voisines qui souffrent, comme le Rio Grande do Sul. » - Séance de travail en petits groupes en portugais, Dialogue 2
Partenaires potentiels pertinents	Les principales parties prenantes impliquées dans la recherche multisectorielle devraient être les suivantes : • Organisations de la société civile • Groupes d'expérience vécue • Des professionnels de la santé variés • Les jeunes	« Pour cela, il faut évidemment que nous ayons des partenaires et des parties prenantes dans l'enseignement et la recherche. Ceux-ci ne doivent pas nécessairement être hébergés dans une université. Nous devons également penser à d'autres entités de recherche qui mènent des recherches dans ce domaine. » - Séance de travail en petits groupes en anglais 2, Dialogue 2 «.....et nous parlons de faire en sorte que les membres de la communauté, y compris les jeunes, soient des parties prenantes ou des partenaires clés, plus des partenaires que des parties prenantes, dans le cadre de la recherche. » - Séance de travail en petits groupes en anglais 1, Dialogue 2 « C'est une question multidisciplinaire, je pense. Des professeurs d'autres institutions, parce que, en fait, il y a des gens qui sont plus préparés dans d'autres endroits, plus mobilisés que nous » - Séance de travail en petits groupes en portugais 2, Dialogue 2

*Certaines citations couvrent deux concepts.

Prochaines étapes/recommandations prioritaires

Compte tenu des multiples facteurs qui influencent l'interaction entre le changement climatique et la santé mentale dans la région ALC, les bailleurs de fonds, les chercheurs et les décideurs politiques devraient s'efforcer d'adopter d'urgence une approche multisectorielle qui considère fondamentalement que la gestion des ressources de la planète est indissociable de la poursuite du développement humain et du bien-être.

Les institutions de financement devraient :

- Créer des pools communs à des institutions de divers secteurs afin d'accroître les financements/ressources disponibles (par exemple, mettre en commun les ressources des financeurs traditionnels de la santé et des financeurs traditionnels de la recherche sur les mesures de sécurité).
- Créer des allocations dédiées au climat et à la santé mentale dans le cadre des flux de financement existants explicitement à long terme (par exemple, la recherche en matière de politique alimentaire).

Les institutions de financement et de recherche devraient donner la priorité aux projets qui :

- Créer ou renforcer les systèmes de surveillance de la santé mentale et du climat ; cela permettra de mieux comprendre les interactions entre le climat épidémiologique et la santé mentale dans la région.
- Créer et valider des outils de diagnostic du climat et de la santé mentale (par exemple, ceux nécessaires pour l'éco-anxiété).
- contenir des éléments pratiques permettant d'améliorer la santé mentale et/ou le bien-être mental dans le contexte du changement climatique au niveau communautaire (de préférence avec une durabilité démontrable et un impact communautaire élevé).

Traduire une base de données de plus en plus étoffée en actions susceptibles de répondre aux effets du changement climatique sur la santé mentale

La base de données probantes actuelle sur l'interconnexion entre changement climatique et santé mentale entraîne l'obligation d'agir au travers de politiques et de pratiques pour protéger les besoins croissants en matière de santé mentale et promouvoir des actions climatiques co-bénéfiques. Comment les données actuelles et les nouvelles connaissances issues de la mise en œuvre de cet agenda peuvent-elles se traduire au mieux par des changements dans les décisions politiques et les pratiques dans les espaces régionaux du climat et de la santé mentale ?

Cette section présente une synthèse des discussions et des résultats d'enquête, en exposant les défis et les possibilités pour implémenter les données probantes produites par la recherche en politique et dans la pratique.

Tableau 5 : Traduire une base de données de plus en plus large en actions susceptibles de répondre aux effets du changement climatique sur la santé mentale*

Conceptualité	Résumé	Citations de soutien exprimées par les participants**
État souhaité	L'ensemble de ces données servira à influencer ou à soutenir les décideurs dans les multiples sphères politiques qui ont un impact sur le lien entre le climat et la santé mentale. Pour ce faire, il faudra éduquer, mobiliser, communiquer et impliquer les décideurs politiques et les différents acteurs de la société (par exemple, les médias pour susciter l'adhésion, le financement et le soutien général pour sensibiliser la communauté).	« Plaidoyer auprès des autorités proposant des mesures de CC pour les communautés vulnérables des Caraïbes et de Hati en particulier (Unité de santé publique et de santé mentale et ministère de l'environnement). Ces questions ne sont pas actuellement à l'ordre du jour... les résultats de la recherche sont présentés ainsi que les effets sur les communautés touchées par les catastrophes liées au changement climatique, y compris l'impact sur les déplacements (migrations internes). - Séance de travail en petits groupes en français, Dialogue 2
Défis	• La santé mentale et le changement climatique sont des questions de santé publique relativement nouvelles; par conséquent, elles ne figurent pas nécessairement dans les programmes d'action politique et sociale • La stigmatisation générale de la société à l'égard de la santé mentale, qui pose des problèmes de sensibilisation et de définition des priorités au niveau politique	« En ce qui concerne le changement climatique, il est difficile de faire le lien. Pourquoi le changement climatique a-t-il eu un impact sur ma qualité de vie ou ma santé mentale ? En matière de qualité de vie, il est parfois facile de faire une association. Dans l'alimentation, il est facile de faire une association aujourd'hui. Dans le domaine de la santé mentale, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une chose voilée.....Premièrement, la santé mentale est une chose voilée, je pense, dans notre population. Du moins, brésilienne. C'est un peu comme cela que je vois les choses. Aborder le thème de la santé mentale est une chose très sérieuse. Vous ne pouvez pas continuer à le

		dire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et l'associer à la question du changement climatique est encore plus complexe....Les gens disent toujours : 'Il faut en parler.' Jusqu'à récemment, nous ne pouvions même pas parler du suicide, par exemple. Nous ne pouvions même pas parler de dépression ». - Séance de travail en petits groupes en portugais, Dialogue 2
Opportunités et catalyseurs	• Exploiter l'intérêt actuel dans le domaine • Mettre l'accent sur les situations de crise climatique aiguës pour souligner l'urgence d'une réponse et la nécessité de solutions à long terme • Tirer parti de la préparation des communautés et de l'action collective	« Le temps est un catalyseur et un facteur de stress - par exemple, l'élévation du niveau des mers, les gens sont conscients que la perte de leur territoire est imminente. L'impact sur les saisons et les précipitations, les récoltes, les mangroves qui protègent les villes côtières, sont également touchés ; ces changements peuvent être un catalyseur pour les décideurs afin qu'ils prennent des mesures. » - Séance de travail en petits groupes en français, Dialogue 2
Partenaires potentiels pertinents	• Parties prenantes au niveau de l'État ou du gouvernement, y compris les ministères de l'environnement et des services de santé • Les parties prenantes non gouvernementales, notamment les représentants des écoles, des universités, des communautés côtières et montagnardes, des personnes handicapées, des organisations de santé mentale, des églises, des communautés agricoles et des pêcheurs, des associations de femmes et de victimes, et des organisations de base • Les entreprises du secteur privé susceptibles, ou perçues comme susceptibles, d'avoir un impact négatif sur	« Tous les niveaux de gouvernement, du bureau du maire au président....Ce sont là des éléments facilitateurs... des facilitateurs dans la création de politiques publiques ou dans la mise en œuvre ou la création et la mise en œuvre de politiques publiques ? » - Séance de travail en petits groupes en portugais, Dialogue 1 «...vous voulez faire participer les parties prenantes qui auront une influence sur l'élaboration

- | | |
|--|--|
| <p>les écosystèmes de la région (par exemple, les producteurs d'engrais, agro-industrie et les grands consommateurs de terres et d'eau)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entités internationales, telles que les agences des Nations unies, les organisations de femmes, les associations médicales, les associations psychologiques et les centres de recherche | <p>de la politique. Il ne s'agit donc pas de faire des recherches, d'obtenir des résultats, de rédiger un document d'orientation et de s'adresser aux personnes qui détiennent le pouvoir. Vous voulez qu'ils participent dès le début, afin qu'ils adhèrent à votre projet et qu'ils fassent partie de la solution dès le premier jour ».</p> <p>- Séance de travail en petits groupes en anglais 2, Dialogue 2</p> <p>« Vous pouvez créer ces politiques, mais vous avez toujours besoin du soutien de la communauté pour aider à les mettre en œuvre. Séance de travail en petits groupes en anglais 2, Dialogue 2</p> <p>« Je pense que cela va de pair avec les influenceurs des médias sociaux pour vraiment attirer l'attention des jeunes, car ils jouent un rôle très important dans le développement de notre avenir et de notre présent. »</p> <p>- Séance de travail en petits groupes en anglais, Dialogue 2</p> |
|--|--|

*Veuillez noter que les résultats se chevauchent, ce qui reflète l'approche synergique qui sera probablement nécessaire pour mettre en œuvre l'agenda de recherche.

**Certaines citations couvrent deux concepts.

Prochaines étapes prioritaires/recommandations aux investisseurs et aux acteurs

Les décideurs politiques devraient :

- Créer des mécanismes d'amélioration de l'éducation et de la formation médicales dans le domaine du climat et de la santé mentale.
- Intégrer le climat et la santé mentale dans les politiques/composantes prioritaires du système de santé (par exemple, le climat et la santé mentale dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, des soins de santé primaires et des réponses aux pandémies).

Les bailleurs de fonds, les décideurs politiques et les chercheurs devraient :

- Réfléchir et concevoir des moyens culturellement appropriés pour traduire les données probantes dans des contextes géographiques, des groupes de population et des langues variés.
- S'engager auprès des médias et d'autres acteurs pour soutenir la traduction des données probantes.
- Investir dans des campagnes de sensibilisation organisées sur le climat et la santé mentale dans la région afin de réduire la stigmatisation.

Discussion : points forts, limites et prochaines étapes du programme de recherche et d'action

Le projet CCM a constitué un exercice novateur et une formidable occasion de recueillir des connaissances sur l'expérience vécue dans une région vaste, multilingue et multiculturelle, dont les pays se situent à tous les niveaux de développement humain. Les points forts et les limites du projet sont brièvement décrits ci-dessous, en vue d'éventuelles prochaines étapes.

Points forts

- Faire émerger des besoins et des expériences qui n'ont pas été entendus auparavant ou qui n'ont pas été pris en compte dans la littérature.
- Diversité des experts réunis et partage au sein des régions et entre elles.
- Possibilité d'échanges universitaires et d'expériences vécues multilingues, qui auraient pu être limités par les barrières linguistiques qui ont traditionnellement créé des cloisonnements dans la région.
- L'engagement significatif de l'expertise de l'expérience vécue guide ce travail.
- Sensibilisation au lien entre le climat et la santé mentale en Amérique latine et dans les Caraïbes.
- Valeur personnelle de la participation pour les participants (y compris des espaces sûrs pour partager ce à quoi eux et leurs communautés sont confrontés, ainsi que le renforcement de leurs compétences, de leurs capacités et de leurs relations).
- Conception d'une nouvelle méthodologie pour la recherche interculturelle sur l'expérience vécue et la gestion de grands ensembles de données qualitatives en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Limites

- Trouver un équilibre entre l'urgence d'élaborer un programme de recherche et d'action pour ce domaine en pleine expansion et la nécessité d'organiser des réunions, d'établir des relations et d'avancer au rythme de la confiance, en particulier avec les groupes fréquemment soumis à des processus de recherche extractifs (c'est-à-dire les peuples et les nations autochtones).
- Aborder l'ampleur et l'enracinement des défis que ce travail cherche à surmonter (secteurs et processus de recherche déconnectés, inégaux et cloisonnés).

- Défis de la convocation virtuelle (par exemple, la technologie est un obstacle pour certains participants).
- Construire des processus (par exemple, le partage des données et l'éthique) à partir de zéro (ce qui est également un point fort).
- Difficulté de trouver un équilibre entre le besoin de normalisation et la contextualisation locale, et nécessité de garantir l'utilisation des terminologies et des conceptions culturelles locales (cela pourrait également être un point fort concernant la manière dont nous avons développé les méthodes à l'échelle mondiale, les groupes de travail ayant la possibilité d'être représentés dans toutes les régions).
- Stigmatisation/tabou de la santé mentale et des questions d'identité sexuelle dans la région. Il est possible que les éléments de la conception de l'enquête liant le nom, le sexe et l'état de santé mentale (bien qu'ils soient confidentiels) aient eu un impact sur les taux de réponse.

Conclusion

Les participants de l'ALC perçoivent et subissent des menaces multiples et variées pour la santé mentale et le bien-être mental en raison d'événements climatiques rampants et aigus. Compte tenu de l'intensité croissante de ces menaces, nous devons établir ensemble des principes fondamentaux pour concevoir des interventions fondées sur des données probantes en matière de climat et de santé mentale, soutenues par une plateforme de diffusion et de mise en œuvre de ces interventions. La réalisation de ces objectifs nécessitera une approche systémique, intersectorielle et interdisciplinaire, et devrait inclure un large éventail de parties prenantes dès les premières étapes. Cette tâche nécessitera un soutien important de la part des acteurs et des bailleurs de fonds régionaux et internationaux, mais elle peut être accomplie grâce à une action unifiée et à des méthodes de travail respectueuses et inclusives.

Audition de la communauté de pratique régionale

À la fin du processus de dialogue, nous avons demandé aux participants de donner leur avis sur ce qu'ils espéraient voir émerger de la Communauté de pratique régionale (RCoP). Pour souligner leurs réflexions, nous fournissons ici une liste de tous les commentaires comme un mur virtuel de mémoire des espoirs de ces pionniers en matière de santé mentale et de climat en Amérique latine et aux Caraïbes (ALC).

- Yo haré procesos de incidencia en la organización donde trabajo para que se aborden tema de salud mental y cambio climático para el beneficio de las comunidades indígenas (Je mènerai des démarches de plaidoyer dans l'organisation où je travaille afin que les problèmes de santé mentale et de changement climatique soient abordés au profit des communautés autochtones).
- Je partagerai une note d'orientation sur le changement climatique et la santé mentale des enfants.
- Je contribuerai en plaidant à l'échelle mondiale en faveur de politiques qui permettent aux jeunes d'être éduqués, formés et employés pour résoudre les problèmes.
- Yo contribuiré a divulgar lo aprendido y discutido. (Je contribuerai à diffuser ce qui a été appris et discuté.)
- Je maintiendrai les liens que j'ai établis aujourd'hui afin d'agir sur les problèmes liés à la santé mentale et aux effets des changements climatiques.
- Je continuerai à faire entendre les voix des jeunes dans le programme sur le climat et la santé mentale. Je m'engagerai également à commencer à sensibiliser le public au lien entre cette question dans ma ville et les espaces dans lesquels je suis impliqué.
- Je réfléchirai à la façon dont ma contribution peut être plus efficace en travaillant avec différents acteurs pour mettre en œuvre de meilleures solutions.
- J'aurai un impact sur ma communauté.
- Je chercherai à intégrer les problèmes liés à la santé mentale et à la Communauté des Caraïbes (CC) intégrés dans l'outil d'information sur les risques de la communauté des Caraïbes (CCRIT) et dans d'autres domaines liés à la résilience communautaire.
- Je veillerai à ce que les contextes avec le moins de capacité soient pris en compte.
- J'assurerai le suivi des conséquences de ce projet et j'aiderai avec tout ce que je peux en cours de route.
- Yo hare mis próximas investigaciones con enfoque de salud mental. (Je ferai mes prochaines recherches en mettant l'accent sur la santé mentale).
- Je continuerai à considérer la santé mentale comme un élément essentiel de la santé mentale.
- De esta comunidad me gustaria ver acciones concretas en el campo de salud mental y cambio climático. (De cette communauté, j'aimerais que des actions concrètes dans le domaine de la santé mentale et du changement climatique existent).
- (J'aimerais que des actions concrètes dans le domaine de la santé mentale et du changement climatique soient menées au sein de cette communauté).
- J'aimerais que des partenariats durables soient effectuées au sein de cette communauté.
- J'aimerais que des moyens pratiques d'avancer en matière de recherche et d'élaboration de politiques pertinentes existent au sein de cette communauté.
- J'aimerais que le tableau de bord / la plateforme soit maintenu après la fin de ce cycle de recherche.

- Une génération de preuves scientifiques plus importante et plus de politiques mises en œuvre.
- De esta comunidad quiero contar con apoyo técnico, político y si fuera posible económico para algunas acciones. (Je souhaite que cette communauté m'apporte un soutien technique, politique et, le cas échéant, économique pour certaines actions).
- J'aimerais qu'une systématisation claire des principales conclusions et de la manière dont nous pouvons lancer des actions soit disponible.
- J'aimerais que davantage de travail de sensibilisation sur la santé mentale et les changements climatiques soit réalisé au sein de cette communauté.
- J'aimerais que des opportunités de recherche collaborative existent au sein de cette communauté.
- J'aimerais que des efforts stratégiques pour intégrer les questions de santé mentale dans les politiques sociales et de développement existantes soient faits.
- J'aimerais que la création de voies de changement accessibles aux jeunes, qu'un rapprochement avec les organisations déjà existantes et des actions de sensibilisation en matière de santé mentale auprès des personnes vivant dans les zones rurales existent au sein de cette communauté.
- J'aimerais que le développement de notre communauté soit accompagné de prise de conscience et d'espoir.

Glossaire

Si vous souhaitez accéder à un glossaire décrivant les concepts pertinents et les principaux mots des programmes de recherche et d'action de Connecting Climate Minds, veuillez le télécharger [ici](#).

Qui a produit ce rapport

Déclaration de contribution de l'auteur

Dr Natalie Greaves, maîtresse de conférences en santé publique, coordinatrice du MPhil/PhD en santé publique et épidémiologie, Faculté des sciences médicales, Université des Indes occidentales (UWI) Cave Hill.

Dr Satish Jankie, maître de conférences en pharmacologie, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine

Dr Shamjeet Singh, maître de conférences en sciences fondamentales intégrées de la santé, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine

Ambassador Gillian M. S. Ambassadrice Gillian M. S. Bristol, Directrice, Latin American Caribbean Centre (ALC), UWI Mona

Dr Elizabeth Mandeville, Consultante Indépendante

Dr Michael Campbell, maître de conférences en sciences du comportement/psychologie et vice-doyen (recherche et études supérieures), UWI Cave Hill

Nienke Meinsma, chargée de cours sur le changement climatique et la santé, Climate Cares Centre, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Jessica Newberry Le Vay, chargée de recherche sur le changement climatique et la politique de santé, Climate Cares Centre, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Didi Thompson, chercheur honoraire, Centre for Health Policy, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Dr Emma J. Lawrance, Climate Cares Centre, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Dr Sandeep Maharaj, Directeur, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine

Il s'agit du travail indépendant des auteurs avec le soutien et la contribution de l'équipe Connecting Climate Minds.

Remerciements

L'équipe de Connecting Climate Minds d'Amérique latine et des Caraïbes remercie tous ceux qui ont contribué à la génération de cette recherche. La diversité géographique de la région a rendu la tâche difficile pour certains participants, et nous exprimons nos plus sincères remerciements à ceux qui ont donné de leur temps et de leur expertise.

Adrian Trotman

Alejandro Herrera-Aguayo

Ana Gabriela Mejia

Ana Sfoggia

Antonia Faustina Xuruc Barreno

António Saraiva

Athena Adoración Flores Torres

Bidyadhar Sa

Carlos Arroyo

Carolina Somarribas Dormond

Cesar Castillo

Chris Oura

Claudia Buchweitz

Cleefedwens Fortuné

Danelia Pineda

Darren K. Dookeeram

Doris Keens-Douglas

Edward Mark

Olga Falceto

Felipe Nora

Frandy Jules

Gabriela Aurora Martínez Ramírez

Garvey Myrvelt Louis Jean

Georgiana Gordon-Strachan

Casco allemand

Gloria Blaise

Grace Kelly Bent

Hariharan Seetharaman

Harvey Vijay Sharma

Heather Armstrong

Jacqueline Laguardia Martinez

Jean Mary Alexandre

Jeremy Collymore

Jonathan Sherin

Katherin Vivianne Fuentes Rodríguez

Kenzy Jean Pierre

Lisa Benjamin

Marcela De la Garma

Marcia Mandepora Chundary

Fil dentaire Mayara

Michael H. Campbell

Nelzair Araujo Vianna

Norton Gilberto Chavarria Francis

Raquel Tupinambá

Renato Oliveira e Souza

Rolando Sierra

Rosa Elizabeth Flores Gómez

Salvador López

Sandra Reid

Satish Jankie

Serafina Espinoza Blanco

Shamjeet Singh

Shane Kirton

Silvel Elías

Vashti-Eve Burrows

Vilma Crovetto

Vinson Bradley Noel

Xóchitl Garza Olivares

En outre, le travail n'aurait pas été effectué sans l'expertise, la diligence, l'intérêt et le soutien des Co-coordonateurs, des personnes ayant vécu une expérience et des jeunes ambassadeurs.

Personnes occupant des rôles de leadership de premier plan :

L'ambassadrice Gillian Bristol et le Dr Sandeep Maharaj.

Co-coordonateurs et facilitateurs : Dr Enrique Falceto de Barros, Docente Investigador Msc Marcos Leonardo Williamson Cuthbert, Dr Marta Rosa Munoz, Dr Fresia Hernandez, Dr Dassaëve Brice, Dr Clemencia Ramirez, Dr Tatiana Camargo, Dr Raquel Santiago et le professeur Jonathan Sherin.

Groupe sur l'expérience vécue : Mme Vashti-Eve Burrows, Mme Gloria Blaise, Mme Raquel Tupinamba et M. Norton Chavarria.

Jeunes ambassadeurs : Mme Ana Gabriela Mejia et M. Harvey Vijay Sharma.

Analystes de recherche : Dr Satish Jankie et Dr Shamjeet Singh.

L'équipe remercie également le Dr Natalie Greaves pour son expertise technique et pour avoir dirigé l'analyse des données qualitatives présentées dans ce rapport.

Financement

Ce projet a été financé par Wellcome.

Conflits d'intérêts

Les auteurs n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer.

Traductions

Merci à Climate Cardinals pour les traductions.



Annexe

Annexe 1 : Points recommandés pour l'intervention politique sur la base de l'examen de la description de la bibliographie

1. Améliorer l'organisation et la prestation des services de santé mentale, notamment ceux qui répondent aux besoins des populations autochtones en matière d'infrastructure de santé mentale en général.⁸
2. Élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à renforcer les capacités des membres de la communauté à prodiguer les premiers soins psychologiques.
3. Élaborer et dispenser des formations aux professionnels de la santé sur les liens entre la santé mentale et les événements climatiques.²⁴
4. Établir des mécanismes de continuité des soins pour les personnes souffrant de santé mentale lorsque la météo est défavorable.²⁴
5. Élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à favoriser le bien-être mental grâce à l'adaptation au changement climatique.²⁴
6. Mettre en œuvre des mécanismes de surveillance passive de la santé mentale, notamment l'outil de diagnostic du International Classification of Disease (CIM-10 ou 11).¹⁰
7. Élaborer des programmes communautaires de promotion de la santé sur l'interaction de la santé mentale et du changement climatique.⁵
8. Discuter du changement climatique pour engager des conversations sur les impacts préjudiciables pour la santé mentale.⁹
9. Utiliser un processus participatif pour l'élaboration de politiques publiques sur le changement climatique et la résilience, en reconnaissant que toute personne a le droit de s'impliquer dans la planification, la prise de décision et l'action aux niveaux local et mondial.⁵

Annexe 2 : Affiche résumant les éléments des résultats de l'examen de la portée narrative

- Résumé de la méthodologie – Examen consacré à la bibliographie publiée entre le 31 janvier 2013 et le 1er juillet 2023, et mené dans sept [7] bases de données électroniques (PsycArticles, PubMed, CINAHL, Cochrane, LILACS [Bibliographie latino-américaine et caribéenne des sciences de la santé], MEDLINE Complete et Google Scholar¹) avec utilisation des stratégies de recherche initiales et étendues. Aucune limite n'a été fixée sur le type d'étude ou de la langue, étant donné la nature émergente du domaine et les multiples langues parlées dans la région géographique d'intérêt.



Climate Events or Threats

Acute and creeping climate events and/or threats had a significant impact on the mental health of individuals). Discussing climate change might affect the mental health of persons i.e., through anxiety related to discussions of climate threat. However, community discussions could facilitate solution-oriented thinking and mitigate negative impacts on mental health (11).

Climate Shocks and Creeping Changes

Climatic changes can be abrupt or gradual. In both instances, these events have implications for mental health and well-being (13). The physical and social stressors associated with climatic events and threats have been linked to depression, anxiety, and post-traumatic stress in adults and children (13, 8).

Climate Shocks

Climate shocks are abrupt weather changes, such as hurricane disasters or tsunamis, that can increase the prevalence of common mental disorders, including psychological distress, grief, major depression, and post-traumatic stress (9, 8).

Creeping Changes

Some climate events occur emerge incrementally over a longer time frame and have been termed 'creeping changes, these include increases in oceanic and atmospheric temperatures, "rising sea levels", "ocean acidification", "ecosystem changes", and "alterations in the land and freshwater".. If persons are unable to adapt their livelihoods to incremental climate change, then both subsistence blue and green economy-based industries can be negatively impacted leading to economic hardship and resultant mental stress (11).

Climate Mitigation Strategy: Green Spaces and Mental Health

Green spaces have facilitated mental well-being in urban settings, simultaneously contributing to positive mental health outcomes and reduced risk of mental disorders (7).

Climate Events, Migration and Mental Health

Climatic extremes can increase mental health risks if they precipitate population displacement and migration [9, 11]. The consequences of migration stress include "reduced self-esteem, poor adjustment to the new location, and increased rates of depression, phobias, and schizophrenia" (11).

Lack of Health Resources

Latin American mental health management is under-resourced due to low research capacity, stigmatization of mental illness, and insufficient funding (11). The region experiences treatment gaps for mental illness, and only approximately 9% of people with depressive disorders received minimally adequate treatment (11). Additionally, there are difficulties with access to primary care due to geographical location, power imbalances related to the healthcare system, and stigma and discrimination, all of which are barriers to adequate care (11).

Increase in mental illness: Climate change vs stress of other circumstances

The frequency and intensity of some types of extreme climate events are expected to increase over the coming decades as a consequence of climate change, suggesting that the associated health impacts including mental health illnesses, such as acute stress, anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD) are likely to increase (15; 11).

Lack of Research on Climate Change and Mental Health

Many developing countries' health systems do not routinely collect mental health data, constraining planning, and research to establish the relationships and mechanisms of climatic influence on mental health (13, 11). There are also research gaps pertaining to the analysis of climate health risks (CHR), migrant and vulnerable groups populations, consequences of exposure to climatic events during pregnancy or early childhood climatic monitoring/forecasting, and the association to social and political factors (13, 11).

Annexe 3 : Programmes de dialogue

Dialogue 1

Temps (minutes)	Ce qu'il faut faire	Comment
0 à 20	Accueil et présentations	
20 à 35	Exercice de visualisation	Exercice de visualisation : « Les gros titres » sur la plateforme Climate Centre Good Games

		Les participants partagent ce qu'ils espèrent obtenir en faisant partie de Connecting Climate Minds et pourquoi ils s'investissent dans ce sujet <i>Imaginez que nous soyons en 2030 et que le projet CCM ait reçu un prix important pour ses réalisations en matière de rapprochement CC/MH dans votre région et de changement pour le climat et la santé mentale par la recherche et l'action. Vous êtes interviewé par un journaliste alors que vous célébrez l'obtention du prix</i> Créer/voter et examiner les titres créés sur la plateforme Good Games
35 à 50	Mise en scène	Brève mise en contexte des liens entre le changement climatique et la santé mentale Qu'entendons-nous dans la région qui nous permette de nous rassembler et de répondre : partager les points saillants de la mise en situation préalable Présentation sur Connecting Climate Minds et questions-réponses
50 à 95	Séance en petits groupes 1 : Besoins régionaux	L'animateur crée le contexte pour une discussion en petits groupes Partager un aperçu des dangers climatiques pour la région Groupes de discussion L'animateur dirige les échanges du groupe sur les défis de santé mentale découlant du changement climatique dans la région. Les questions posées aux participants étaient les suivantes : • De votre point de vue, quels sont les risques climatiques qui vous préoccupent le plus en termes de santé mentale et de bien-être ? • Pour chaque risque, discutez des éléments suivants : ○ Qui sont les personnes touchées ? Y a-t-il des groupes plus à risque ? ○ Quels sont les résultats en matière de santé mentale et de bien-être associés à ce risque ? ○ Comment ce danger pèse-t-il spécifiquement la santé mentale et le bien-être; quel est le type de mécanisme utilisé, par exemple le logement, les moyens de subsistance, etc ○ Encourager les gens à examiner différents types de mécanismes, par exemple sociaux, biologiques, culturels, environnementaux ○ Adaptation au changement climatique et atténuation du changement climatique - que fait-on, que peut-on faire ? ○ Actions en cours/possibles pour améliorer ou promouvoir la santé mentale et le bien-être dans ce contexte Points forts de la plénière
95 à 105	Pause	

105 à 110	Prévisualisation	Le dessinateur partage une première ébauche reflétant une partie du contenu de la session jusqu'à présent. L'animateur invite les participants à partager dans le chat la façon dont l'image est perçue.
110 à 160	Séance de travail en petits groupes 2 : Lacunes en matière de données probantes et priorités de recherche	Séance de travail en petits groupes [mêmes participants, animateur et rapporteur que lors de la première séance en groupes restreints] En examinant le tableau des dangers de la séance de travail 1 en petits groupes comme point de départ, les participants sont guidés pour initier des réflexions dans des domaines de recherche recherches inexplorés. Les animateurs invitent 2 ou 3 animateurs à partager quelques brèves réflexions
160 à 170	Dessin de réflexion sur les résultats du dialogue	Les participants examinent individuellement chaque dessin animé et partagent leurs réflexions. Cela peut aller de suggestions de changements pour le rendre plus précis, à partager la façon dont il est lié à notre réalité, ou tout autre éclairage.
170 à 180	Récapitulatif et étapes suivantes	L'animateur partage un résumé de haut niveau de la session, remercie tout le monde et célèbre ce premier rassemblement de la communauté régionale. Les participants répondent à un bref sondage pour donner leur avis sur le dialogue

Dialogue 2

Temps (min)	Ce qu'il faut faire	Comment
0 à 5	Exercice sur la carte du monde	L'animateur demande aux participants de placer une icône « étoile » à l'endroit où ils se trouvent actuellement, puis de prendre l'icône « cœur » et de la placer à l'endroit qu'ils aimeraient visiter un jour ou à un endroit qu'ils ont visité et qu'ils ont vraiment aimé / se sont sentis particulièrement connectés.
5 à 15	Accueil et présentations	
15 à 30	Partage des mises à jour	Présentation sur les progrès et les résultats mondiaux et régionaux du dialogue 1, notamment la vision et les thèmes de recherche prioritaires.

30 à 50	Commentaires sur les thèmes de recherche prioritaires	Jamboard partagé à l'écran. L'animateur présente l'activité thématique de recherche prioritaire et demande aux participants de réfléchir aux questions suivantes : Questions de recherche • Est-ce un thème important ? Ajouteriez-vous ou changeriez-vous quelque chose ? • Partagez des idées sur des ensembles de données, des mesures ou des méthodes qui pourraient être appliquées pour y remédier. Sujets de recherche • Quelles sont les connaissances les plus utiles à ce sujet pour le comprendre afin d'y répondre ? • Que voulez-vous savoir en premier ? La musique joue et les participants travaillent indépendamment sur Jamboard à leur propre vitesse.
50 à 55	Mise en place pour les groupes	L'animateur pose les bases de la discussion en petits groupes. Intéressé par le « comment », qui comprend les principes et les résultats souhaités pour la recherche, les politiques et les pratiques dans la région. La discussion permettra de cibler les actions et les investissements pour à la fois mettre en œuvre le programme de recherche dans la région et garantir que les preuves sur le lien entre le climat et la santé mentale soient traduites en politiques et en pratiques
55 à 90	Groupe restreint 1	Huit groupes restreints. Les 4 premiers sur le thème « Créer des connaissances par la recherche » (p. ex., comment pouvons-nous mettre en œuvre au mieux le programme de recherche ?) et les 4 autres sur « Favoriser des politiques et des mesures fondées sur des données probantes » (p. ex. Comment traduire la base croissante de données probantes en actions dans les politiques et les pratiques ?). Chaque groupe utilise un Jamboard pour la discussion : 1) A quoi cela ressemble-t-il quand tout est fait correctement ? 2) Quelles opportunités et quels catalyseurs existent ? 3) Quels défis devons-nous relever ? 4) Qui devraient être nos partenaires et nos parties prenantes ? Points forts de la plénière
90 à 100	Pause	
100 à 105	Illustrez vos sentiments	L'animateur accueille tout le monde à nouveau et invite tous ceux qui souhaitent participer à prendre un morceau de papier et un stylo / marqueur (ou numérique) - et illustrez par le dessin comment ils se sentent aujourd'hui. Toute personne le souhaitant est invitée à montrer son image et à partager quelques réflexions.

105 à 125	Configuration du spectre	L'animateur présente et explique l'activité. Partager l'écran de Jamboard. Conçu pour révéler la diversité des perspectives et des options autour de différents concepts et pour les organiser en un spectre significatif. Cette activité vise à éclairer l'éventail de perspectives du groupe et à organiser ces perspectives dans un continuum. Question : <i>Que signifient ces concepts pour vous ?</i> Se concentrant sur un tableau à la fois, l'animateur demande à chacun de générer silencieusement un point de vue autour de ce concept et de l'écrire sur une note collante sur le Jamboard. Les gens peuvent en ajouter plusieurs. Une fois les notes collantes postées, l'animateur travaille avec le groupe pour les classer dans une gamme horizontale d'idées. Les notes collantes exprimant des perspectives ou des options similaires doivent être placées les uns à côté des autres. Les notes collantes qui semblent être aberrantes doivent être isolées; elles peuvent parfois finir par définir les limites de la fourchette. Répéter avec les concepts restants. À la fin, demandez des observations et des éclairages sur la configuration du terrain. Et si une perspective ou une option a été exclue. Si oui, ajoutez-la et trie à nouveau au besoin.
125 - 155	Séance de travail en groupes restreints 2	L'animateur présente la deuxième série de sessions en groupes restreints et fournit un résumé d'une durée de 2 minutes des contributions du Jamboard de la première session. Les 8 groupes de départ se réunissent à nouveau, développent et complètent leurs réflexions initiales. Les groupes sont autorisés à poursuivre sur le thème de discussion ou à passer à l'autre thème.
155 à 175	Je vais... Je veux...	L'animateur demande à chacun de réfléchir personnellement à la façon dont il contribuera à cet espace, et de partager une déclaration « Je vais » dans le chat, mais appuyez uniquement sur Entrée quand on lui demande de le faire. Après une minute, l'animateur invite tout le monde à appuyer sur Entrée en même temps pour faire apparaître les déclarations. Cela est répétée avec une déclaration du genre « Dans cette communauté, j'aimerais voir... ».
175	Synthèse et prochaines étapes	L'animateur fait un résumé général de la session, remercie tout le monde et indique les prochaines étapes. Les participants répondent à un bref sondage pour donner leur avis sur le dialogue

Annexe 4 : Méthodologie d'analyse des dialogues 1 et 2



Analytic Data reduction steps-Dialogue 1

- Four analysts (NG, SM, SJ, and SS) from varied health sciences backgrounds and who were involved in either the design and or execution of the dialogue coded the data and formulated the thematic concepts.
- The analysts first established consistency in interpretation of codes and coding method by independently coding 4 pages of dialogue with subsequent discussion and resolution of differences. Once this quasi- interrater reliability was established the transcript data set was divided amongst the analysts. Each transcript was then coded by one analyst with subsequent quality check for consistency in application of the coding frame by a second analyst.
- A group discussion was held after the coding of 4 FG transcripts to discuss emerging themes and the steps to be taken in condensing the data using a framework/ matrix analysis method (in this instance the goal was to progress from basic to organizing themes, to an overarching global theme).



Analytic Data reduction steps-Dialogue 2- Jamboards

Google Jamboard sheets from the refinement of research question activity were divided among the analysts (NG, GB, SM, SS and SJ). The analysts then compared all responses to a given question with original thematic summaries from dialogue 1, with the aim of identifying any critiques, changes (including expansions) to the questions/ thematic scope of the questions as articulated). The changes as articulated by participants were then summarized as eight priority research themes reflected in 26 questions to inform the research agenda in the LAC. (These questions were shared with participants in the post dialogue survey).

Annexe 5 : Critères de sélection des thèmes de recherche prioritaires

Les critères de sélection des thèmes de recherche prioritaires ont été établis à la suite de discussions avec des experts du monde entier dans tous les secteurs et disciplines et en s'inspirant des critères de sélection utilisés dans d'autres exercices d'établissement des priorités de recherche.²⁵ Les critères ont été appliqués par consultation au sein de l'équipe d'analyse.

- Le thème de recherche répond-il à un manque de preuves ?
- Le thème de recherche est-il susceptible d'éclairer la prise de décision en matière de politique et sa faisabilité ?
- Reflète-t-elle un ou plusieurs des éléments suivants :

- a identifié les plus grands défis en matière de santé mentale liés au changement climatique dans la région
- a identifié les risques climatiques les plus importants dans la région
- les éléments dont les décideurs politiques ont le plus besoin pour répondre aux besoins émergents / surmonter les obstacles à l'action
- l'alignement sur ce que les experts ayant une expérience vécue ont exprimé comme étant des défis à relever dans la région
- Est-il possible d'entreprendre cette recherche ?
- Est-il formulé de manière à être compréhensible, spécifique et pratique pour que la communauté des chercheurs puisse s'y intéresser de manière significative ? Un chercheur ou un bailleur de fonds disposant d'une expertise pertinente pourrait-il comprendre ce thème ?
- Est-il suffisamment spécifique pour être significatif et guider une recherche ciblée (s'il est trop large ou vague, il n'aidera pas à cibler les ressources de manière significative)
- Il aide les bailleurs de fonds à investir dans ce domaine (réfléchir à ce qui est pertinent au niveau régional)

Appendice 6 : Cadres de codage pour l'agenda de recherche et l'agenda d'action

Catégorie de recherche	Sous-catégories
1. Impacts, risques et groupes vulnérables Cette catégorie vise à améliorer notre compréhension de la manière dont la santé mentale est affectée par le changement climatique. Par exemple, quels résultats en matière de santé mentale sont affectés ou menacés, la prévalence, la gravité, le coût économique et sociétal de ces impacts, et qui est le plus vulnérable à ces impacts. Cette catégorie comprend également les façons dont nous pouvons améliorer notre compréhension des répercussions des changements climatiques	<u>Considérations transversales à garder à l'esprit pour toutes les sous-catégories :</u> Calendrier Variation géographique
	1.1. Recherche axée sur la prévalence, la gravité et la nature de l'expérience des différents résultats, défis et expériences en matière de santé mentale touchés par les différents aspects du changement climatique. Il peut s'agir de recherches visant à comprendre l'émergence d'expériences de santé mentale spécifiques au climat et leur lien avec des défis déjà définis en matière de santé mentale.
	1.2. Quantifier la part du fardeau de la santé mentale (y compris la mortalité) causée par le changement climatique.
	1.3. Comprendre les facteurs de risque pour la santé mentale affectés par les changements climatiques ainsi que les facteurs de protection.
	1.4. Déterminer les sous-groupes de population (p. ex. démographie, moyens de subsistance, stade de vie, problèmes de santé mentale préexistants) qui sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale causés par les changements

sur la santé mentale - les méthodes et les paramètres dont nous avons besoin pour évaluer et surveiller la santé mentale de façon pertinente aux changements climatiques, adaptée au contexte, comparable, etc.	climatiques, et inversement ceux qui font preuve de résilience face à ces effets (c.-à-d. les groupes vulnérables). 1.5. Quantifier le coût (économique, social, etc.) du fardeau supplémentaire que représente pour la santé mentale le changement climatique et l'insuffisance de l'action climatique. 1.6. Recherche de méthodes pour identifier les moyens les plus appropriés d'évaluer et de surveiller les impacts des changements climatiques sur la santé mentale [y compris l'adaptation d'échelles préexistantes, la création de nouvelles échelles, la détermination de mesures et d'indicateurs appropriés pour la santé mentale à inclure dans des processus mondiaux comme Lancet Countdown]. Cela peut également inclure la nécessité d'une validation interculturelle et de l'élaboration de mesures adaptées à la culture.
2. Voies et mécanismes Cette catégorie vise à améliorer notre compréhension de la <i>manière dont</i> la santé mentale est affectée par le changement climatique. Nous nous intéressons aux thèmes de recherche qui peuvent aider à identifier, catégoriser et comprendre les différentes façons dont le changement climatique ou l'action climatique peuvent influencer la santé mentale. Il peut s'agir de voies et de mécanismes de nature biologique, psychologique, sociétale ou environnementale, qui peuvent être directs ou indirects. Notez que les mécanismes peuvent inclure des mécanismes pour le développement, le maintien et/ou la résolution des défis mentaux, donc cela inclut également des mécanismes pertinents pour guider le développement ou comprendre le fonctionnement des	<u>Considérations transversales à garder à l'esprit pour toutes les sous-catégories :</u> <i>Quels facteurs sont liés à une vulnérabilité accrue ou à une résilience accrue pour les résultats associés en santé mentale ?</i> 2.1. Catégoriser et comprendre les mécanismes sociaux par lesquels les changements climatiques ont un impact négatif sur la santé mentale [par exemple, modification des moyens de subsistance, perturbation des pratiques culturelles, insécurité alimentaire et hydrique, migrations forcées, facteurs politiques] 2.2. Catégoriser et comprendre les mécanismes environnementaux par lesquels les changements climatiques ont un impact négatif sur la santé mentale [par exemple pollution atmosphérique, exposition réduite à la biodiversité]. 2.3. Catégoriser et comprendre les mécanismes psychologiques par lesquels les changements climatiques ont un impact négatif sur la santé mentale [par exemple, comment la température affecte les changements cognitifs pertinents aux symptômes des problèmes de santé mentale]. 2.4. Catégoriser et comprendre les mécanismes biologiques par lesquels le changement climatique a un impact négatif sur la santé mentale [par exemple, les impacts des médicaments psychotropes sur la thermorégulation, les facteurs neuro-développementaux]. 2.5. Comprendre les mécanismes par lesquels les actions climatiques ou les interventions en faveur de la santé mentale sont bénéfiques pour le climat et la santé mentale (c.-à-d. mécanisme co-bénéficiaire). 2.6. Recherche méthodologique visant à identifier les moyens les plus appropriés pour évaluer et surveiller les voies et les mécanismes par lesquels le changement climatique a un impact négatif sur la santé mentale et le bien-

interventions	être (par exemple, cartographie des systèmes à travers les disciplines).
3. Avantages de l'action climatique pour la santé mentale [adaptation et atténuation] (en anglais) Cette catégorie porte sur la manière dont les mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, dans tous les secteurs, peuvent également avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale. Il s'agit notamment de quantifier les coûts et les avantages de l'action climatique pour la santé mentale, de comprendre ce qui est nécessaire pour soutenir une meilleure harmonisation entre l'action climatique et l'action en matière de santé mentale, et de déterminer où cette intégration se produit déjà dans les stratégies et les politiques.	3.1. Identifier les actions climatiques qui intègrent ou s'alignent sur les bénéfices pour la santé mentale [actions climatiques co-bénéfiques, par exemple l'augmentation de la couverture arborée dans les villes].
	3.2. Quantification des co-bénéfices de l'action climatique pour la santé mentale (y compris le nombre de personnes qui en bénéficient, l'ampleur des effets, les considérations économiques).
	3.3. Explorer des différences potentielles dans les coûts et les avantages pour la santé mentale de l'action climatique selon les sous-groupes de population (par exemple, la démographie, les moyens de subsistance, les étapes de la vie).
	3.4. Comprendre les structures de gouvernance et les outils d'aide à la décision qui permettent d'harmoniser l'action pour le changement climatique et pour la santé mentale dans tous les secteurs.
	3.5. Cartographie et suivi de l'intégration de la santé mentale dans les politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique dans tous les secteurs [par exemple, les plans nationaux d'adaptation, l'énergie, les transports, l'alimentation, l'eau, l'agriculture].
	3.6. Étudier les possibilités d'intégrer la santé mentale dans d'autres domaines prioritaires liés au climat , tels que les pertes et dommages et le financement climatique.
	3.7. Déterminer les meilleures approches pour l'action climatique (par exemple, la réduction des émissions ou l'adaptation au changement climatique) dans le secteur de la santé mentale (veiller à ce que les installations psychiatriques puissent être maintenues au frais pendant les vagues de chaleur ; projets d'espaces verts dans les installations de soins de santé mentale).
	3.8. Recherche méthodologique visant à identifier les moyens les plus appropriés pour évaluer et contrôler les bénéfices de l'action climatique pour la santé mentale [par exemple, approches locales, méthodes d'attribution et de quantification des co-bénéfices, méthodes d'évaluation des implications pour la santé mentale des décisions prises dans d'autres secteurs].

4. Interventions/solutions en santé mentale dans le contexte du changement climatique Cette catégorie concerne l'identification des interventions/solutions les plus efficaces pour soutenir la santé mentale dans le contexte du changement climatique. Il peut s'agir d'apporter un soutien à des personnes qui subissent déjà des effets négatifs sur leur santé mentale, ou de réduire le risque ou la gravité de futurs effets négatifs sur la santé mentale. Il s'agit notamment d'apprendre à partir des connaissances détenues par différentes disciplines, communautés et cultures, de comprendre comment les interventions existantes en matière de santé mentale sont affectées par le changement climatique, d'identifier et d'évaluer les interventions existantes qui sont pertinentes dans le contexte du changement climatique, et de développer de nouvelles interventions. Les interventions sont pertinentes à tous les niveaux (individu, famille, communauté, systèmes) et dans tous les secteurs.	<u>Considérations transversales à garder à l'esprit pour toutes les sous-catégories :</u> <i>NIVEAU (par exemple)</i> <i>Individu, famille, communauté, systèmes</i> <i>MÉCANISME (par exemple)</i> <i>Biological, Psychological, Social, Environmental</i> <i>SECTEUR (par exemple)</i> <i>Éducation, soins de santé, santé publique</i> <i>Les considérations relatives à l'efficacité comprennent l'impact sur différents groupes de population, et les considérations relatives à la mise en œuvre peuvent inclure les fournisseurs, le coût et le temps.</i> 4.1. Comprendre les différentes façons de savoir, d'être et de faire dans différentes cultures et communautés qui peuvent renforcer la résilience individuelle, communautaire et écologique 4.2. Comprendre comment les interventions existantes en matière de santé mentale sont affectées par le changement climatique 4.3. Identifier et évaluer les interventions en santé mentale qui sont déjà conçues pour le contexte du changement climatique ou pertinentes à celui-ci et/ou qui intègrent les considérations liées au changement climatique 4.4 Modifier, mettre en œuvre et évaluer les interventions en santé mentale pertinentes pour qu'elles soient adaptées aux impacts liés au climat ? 4.5. Co-conception, mise en œuvre et évaluation de nouvelles interventions répondant aux besoins en santé mentale liés au climat 4.6. Comparer le rapport coût-efficacité, les considérations relatives à la mise en œuvre et l'efficacité des interventions dans un contexte particulier et pour un groupe de population donné afin de déterminer les « meilleurs achats ».
---	--

	4.7. Identifier, développer et évaluer des approches de sensibilisation et de renforcement des capacités afin de perfectionner la main-d'œuvre pour reconnaître et répondre aux impacts de la crise climatique sur la santé mentale (par exemple, professionnels de la santé mentale, intervenants d'urgence).
--	---

Annexe 7 : Collecte et stockage des données

Dialogues

Les dialogues ont été menés virtuellement sur Zoom. Les échanges et les groupes de discussion ont été enregistrés et transcrits par des prestataires tiers (Way with Words and Absolute Translations) et les commentaires du chat Zoom ont été sauvegardés. Dans l'échange 1, des documents Word ont été utilisés pour prendre des notes lors des discussions en petits groupes. Dans l'échange 2, Jamboard a été utilisé pour prendre des notes et pour permettre aux participants de contribuer directement aux commentaires.

Enquêtes

La distribution de l'enquête et la collecte des données ont été effectuées à l'aide de la plateforme en ligne Qualtrics. Toutes les données de l'enquête ont été collectées par l'Imperial College London et les données anonymes ont été communiquées à l'UWI pour analyse.

Stockage et partage des données

Les données ont été stockées et gérées par l'Imperial College London à l'aide d'un serveur sécurisé. L'UWI était un contrôleur de données conjoint pour les données fournies à ce projet pour ALC et responsable du stockage et du partage sécurisés des données avec l'Imperial College de Londres et les équipes d'analystes régionaux. Les données seront conservées par l'Imperial College London pendant 10 ans après la fin de l'étude.

Annexe 8 : Risques climatiques dans la région ALC^{22, 26}

Risques climatiques observés dans la région ALC et changements prévus

Pour guider des discussions éclairées sur les conséquences actuelles et potentielles du changement climatique actuel et futur dans la région sur la santé mentale, il était essentiel de s'appuyer sur des connaissances scientifiques en matière de climat. Le Centre pour le climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CCCR) a établi une cartographie des risques climatiques antérieurs et prévus dans la région afin d'éclairer les dialogues et le programme de recherche. Voici un résumé des risques liés au climat que la région ALC a connus au cours des 30 dernières années, et de leur augmentation prévue en raison du changement climatique jusqu'en 2030 environ.

Il est important de souligner que les données recueillies pour les périodes passées et futures diffèrent non seulement en termes de résolution spatiale, mais sont également basées sur des principes sous-jacents différents. Les premières proviennent d'observations ou d'événements documentés comme ceux signalés par les services météorologiques nationaux et sont agrégées à l'échelle du pays. Ces derniers proviennent d'études basées sur la modélisation climatique et de rapports d'évaluation publiés par le

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui se situent à une échelle spatiale plus granulaire. Pour la même raison, les catégories de risques liés au climat dans les périodes passées et futures peuvent parfois ne pas être identiques, mais sont généralement comparables ou liées. Par exemple, les inondations qui sont signalées comme un risque climatique important au cours des 30 dernières années ne sont pas un résultat direct des modèles climatiques globaux (MCG). Au lieu de cela, la variable météorologique sous-jacente (précipitations) des simulations des MCG est utilisée pour établir des indices qui peuvent être considérés comme un indicateur des inondations potentielles dans un climat de réchauffement futur.

ALC

La région ALC est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Ces dernières années, cette région a connu de fortes sécheresses, des incendies de forêt, des inondations, des glissements de terrain, des tempêtes et des températures extrêmes, comme le montre la base de données internationale sur les catastrophes EM-DAT. Il convient de noter que le nombre limité d'événements extrêmes enregistrés (par exemple, les températures extrêmes) peut être dû à l'absence d'enregistrements dans les données EM-DAT pour diverses raisons, telles qu'un réseau médiocre ou limité d'observations par satellite et en surface sur la région, ou des rapports limités de la part des services météorologiques nationaux. En outre, l'agrégation spatiale des données à l'échelle du pays rend difficile la cartographie de l'occurrence des risques passés pour les établissements humains. Le nombre total de personnes touchées, tel qu'il est indiqué dans l'EM-DAT, n'est donc pas toujours véritablement représentatif de la fréquence des aléas climatiques sous-jacents. Par exemple, un pays d'Amérique latine et des Caraïbes peut avoir connu de fréquentes vagues de chaleur, mais si ces événements n'ont pas été enregistrés ou s'ils se sont produits dans des régions inhabitées, le nombre total d'événements mentionné ci-dessous peut être sous-estimé.

Sécheresses précédentes

C'est au Brésil que les sécheresses et les incendies de forêt ont été les plus fréquents, affectant ainsi ^{vi} le plus grand nombre de personnes. Au total, 15 événements de ce type ont touché en moyenne 7,6 millions de personnes entre 1991 et 2022 (figure 1, en haut). Au cours de la même période, 1,4 million, 1,2 million et 1,1 million de personnes en moyenne ont également été touchées en Haïti, au Mexique et au Guatemala, respectivement, à la suite de 5 à 7 événements de ce type dans ces pays.

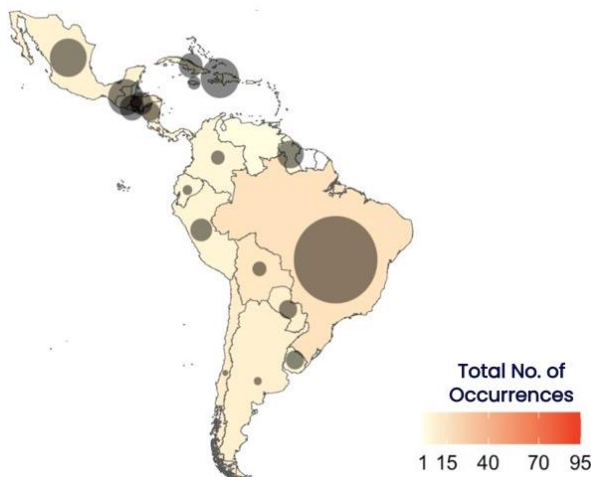
^{vi} Note, la définition EM-DAT du « total des personnes touchées » représente « le total des personnes blessées, touchées et sans-abri ».

Drought and Wildfire

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M

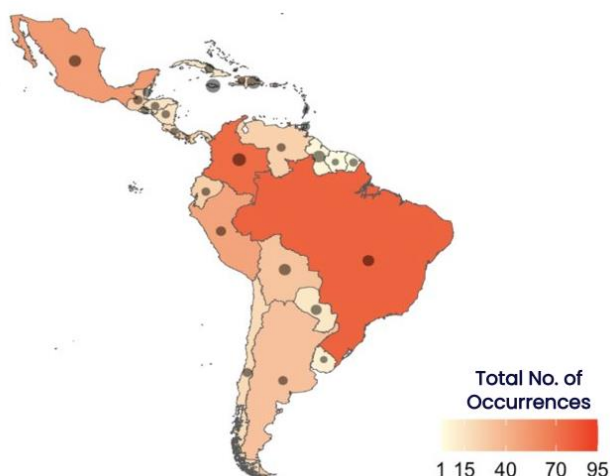


Flood and landslide

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M



Storm and Extreme Temperature

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M

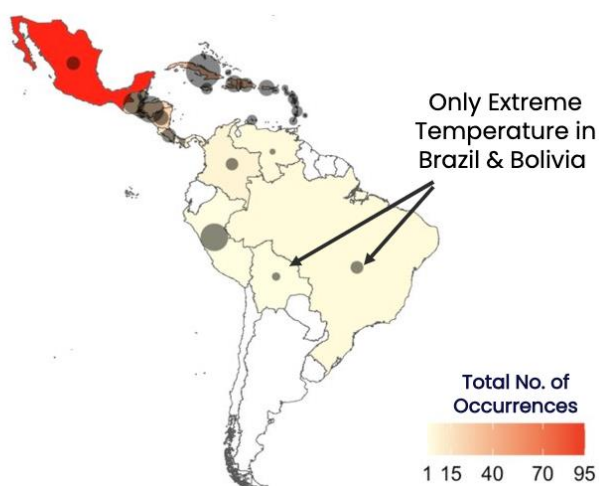


Figure 1. Nombre de sécheresses et d'incendies de forêt (en haut), d'inondations et de glissements de terrain (au milieu) et de tempêtes et de températures extrêmes (en bas) signalés entre 1991 et 2022. La légende rouge représente le nombre total d'occurrences de chaque catégorie de danger entre 1991 et 2022, la taille du cercle noir est représentative de la population moyenne touchée au cours de cette période.

Inondations précédentes

Les inondations et les glissements de terrain ont été les plus nombreux au Brésil, suivi par la Colombie, avec 78 et 74 aléas enregistrés entre 1991 et 2022 (figure 1, au milieu) dans les deux pays respectivement. Parmi les pays où le nombre de personnes touchées est le plus élevé figure la République dominicaine, où 167 000 personnes ont été affectées par 19 événements hydrologiques de ce type. De même, en Colombie, environ 155 000 personnes ont été touchées par 74 événements de ce type au cours de cette période.

Précédent Températures et tempêtes extrêmes (chaudes)

Le nombre de tempêtes et de températures extrêmes a été particulièrement élevé au Mexique, où 92 événements de ce type ont touché près de 94 000 personnes entre 1991 et 2022 (figure 1, en bas). Cuba et le Honduras sont les pays dont la population est la plus touchée par ces événements météorologiques. Alors qu'environ 970 000 personnes ont été touchées en moyenne par 31 événements de ce type à Cuba, le Honduras a enregistré environ 545 000 personnes touchées par 19 événements au cours de la même période. Seules les données sur les températures extrêmes (et non les tempêtes) ont été rapportées pour le Brésil et la Bolivie dans l'EM-DAT.

Projections futures

Les projections futures sont basées sur le scénario d'émissions du milieu de la route (SSP2-4.5 Shared Socio-economic Pathway) de l'ensemble multimodèle de MCG du Projet de comparaison de modèles couplés - Phase VI (CMIP6) fourni dans le GIEC, ²⁰²¹². Bien qu'il ne s'agisse pas du scénario d'émissions le plus pessimiste, le SSP2-4.5 suppose que les engagements pris en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris ne sont pas respectés et que le réchauffement climatique de 2 °C n'est pas évité. Les MCG ont une sensibilité climatique variable et diffèrent généralement aussi dans leur représentation des processus du système terrestre. Bien que leurs projections de l'intensité d'un danger particulier dans l'avenir puissent donc différer malgré un signal persistant dans les enregistrements observés historiques, la direction du signal (c.-à-d. un changement positif ou négatif d'un danger climatique) est généralement plus robuste dans l'ensemble des MCG.

- **Températures moyennes et extrêmes :** Les projections montrant la variation de température moyenne sur les terres exposées aux vagues de chaleur en 2030 par rapport à la période 1986-2005 indiquent que les régions tropicales d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et de Cuba, ainsi que les régions côtières du Mexique sont les plus exposées à ces risques (degré de confiance moyen) (illustration 2a). Cependant, les bandes grises visibles sur l'ensemble des modélisations de l'illustration 2 indiquent qu'il n'y a pas suffisamment de consensus sur les modèles climatiques.
- **Sécheresses et incendies de forêt :** Ces projections montrent également que les terres les plus susceptibles d'être exposées à une augmentation des incendies de forêt se trouvent dans le nord de l'Argentine, dans les régions les plus peuplées du Brésil et dans certaines zones du Mexique (degré de confiance élevé) (illustration 2b).
- **Fortes précipitations et inondations :** L'intensité et la fréquence des précipitations extrêmes et des inondations pluviales devraient augmenter (confiance moyenne) à partir d'un réchauffement climatique de 2°C (GIEC, 2021). Le changement projeté des précipitations annuelles totales pour 2030 sur la base des données de 1986 à 2005 montre que l'augmentation des précipitations sera la plus forte en Amérique du Sud (illustration 2c) (degré de confiance moyen à élevé). Toutefois, l'Amérique centrale et les îles des Caraïbes sont plus susceptibles de connaître une baisse des précipitations moyennes (confiance faible).

- Élévation du niveau de la mer : Il est extrêmement probable que l'élévation relative du niveau de la mer se poursuive dans les océans entourant l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, contribuant à l'augmentation des inondations côtières dans les zones de faible altitude (degré de confiance élevé) et au recul du trait de côte le long de la plupart des côtes sablonneuses (degré de confiance élevé).
- Cyclones tropicaux : Les modèles prévoient généralement une augmentation de la fréquence et de l'intensité des cyclones tropicaux de catégorie 4-5 dans cette région (confiance moyenne). Bien que l'amplitude (montrant les différentes variations selon les modèles) soit importante, l'augmentation médiane devrait être d'environ 3 % par rapport à la période 1986-2005.

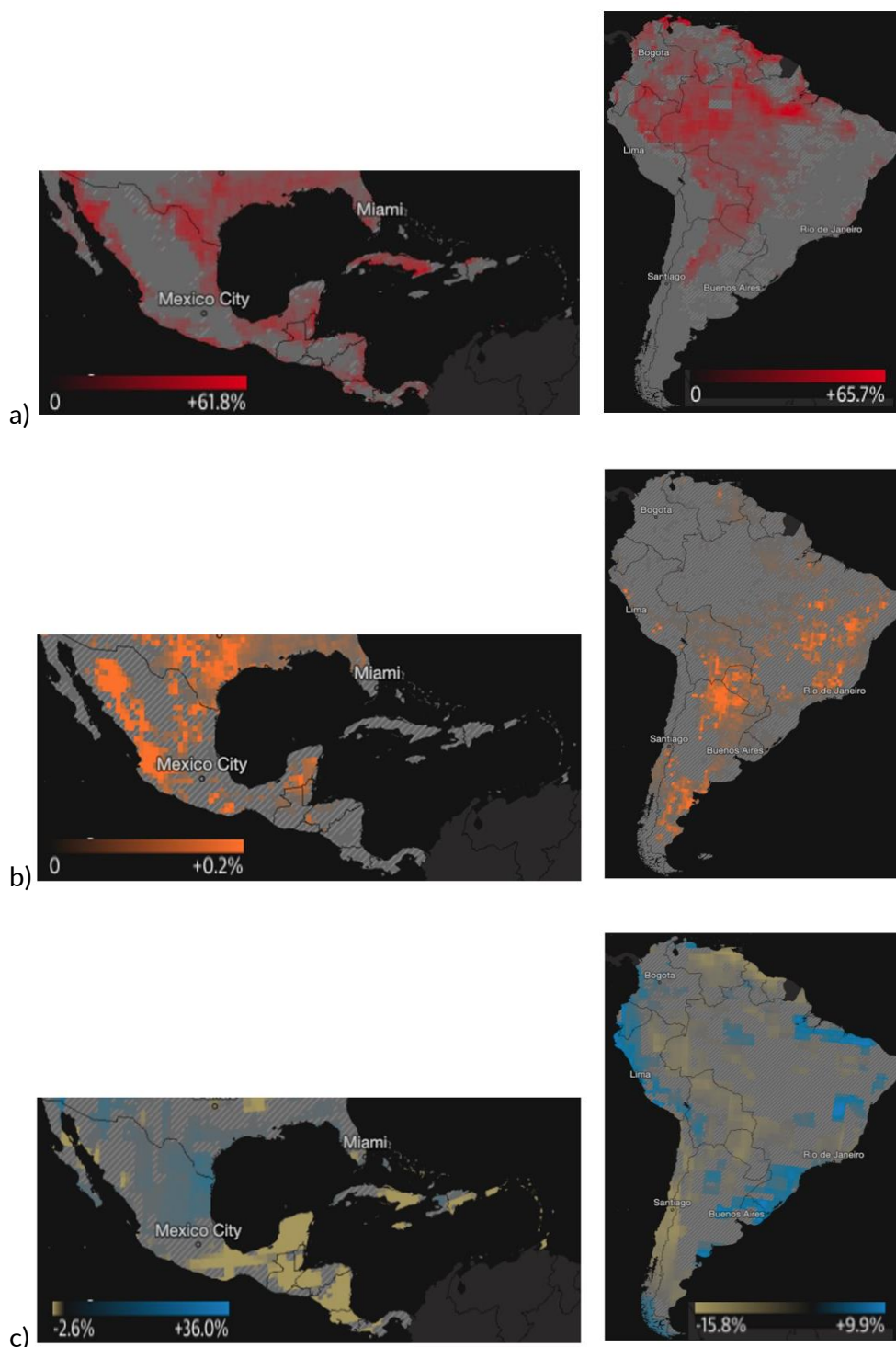


Illustration 2. Changements projetés dans a) les terres exposées aux vagues de chaleur, b) les terres exposées aux incendies de forêt et c) les précipitations annuelles totales pour 2030 par rapport à la période 1986-2005 dans le cadre du scénario médian d'émissions SSP2-4.5.

Remarque : Les informations précises sur les projections et le degré de confiance qui leur est associé proviennent de « Les Bases des sciences physiques », la contribution du groupe de travail I du GIEC au sixième rapport d'évaluation « Changement climatique 2021 » : les bases de la science physique » et le document associé de l'[Atlas interactif du GIEC](#) et des fiches d'information régionales qui y sont associées : [Fact Sheets | Climate Change 2021: The Physical Science Basis \(ipcc.ch\)](#) [EM-DAT - The international disaster database \(emdat.be\)](#)

Références

- ¹ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States*. (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ² Macpherson, C. C. & Akpinar-Elci, M. Caribbean Heat Threatens Health, Well-being and the Future of Humanity: Table 1. *Public Health Ethics* **8**, 196–208 (2015).
- ³ Rataj, E., Kunzweiler, K. & Garthus-Niegel, S. Extreme weather events in developing countries and related injuries and mental health disorders - a systematic review. *BMC Public Health* **16**, (2016).
- ⁴ Azuero, A. J. *et al.* Suicide in the Indigenous Population of Latin America: A Systematic Review. *Revista Colombiana de Psiquiatría* **46**, 237–242 (2017).
- ⁵ Kelman, I. *et al.* A review of mental health and wellbeing under climate change in small island developing states (SIDS). *Environ. Res. Lett.* **16**, 033007 (2021).
- ⁶ Guo, Y., Wen, B., Wu, Y., Xu, R. & Li, S. Extreme temperatures and mortality in Latin America: Voices are needed from the Global South. *Med* **3**, 656–660 (2022).
- ⁷ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States*. (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ⁸ Rojas-Rueda, D., Vaught, E. & Buss, D. Why a New Research Agenda on Green Spaces and Health Is Needed in Latin America: Results of a Systematic Review. *IJERPH* **18**, 5839 (2021).
- ⁹ Mascayano, F. *et al.* Suicide in Latin America: a growing public health issue. *Revista de la Facultad de Ciencias Medicas* **72**, 295–303 (2015).
- ¹⁰ Parry, L. *et al.* The (in)visible health risks of climate change. *Social Science & Medicine* **241**, 112448 (2019).
- ¹¹ Daray, F. M. *et al.* Determinants and geographical variation in the distribution of depression in the Southern cone of Latin America: A population-based survey in four cities in Argentina, Chile and Uruguay. *Journal of Affective Disorders* **220**, 15–23 (2017).
- ¹² World Health Organization (WHO). *Mental health and climate change: policy brief*. (World Health Organization, 2022).
- ¹³ Lawrance, E. L., Thompson, R., Newberry Le Vay, J., Page, L. & Jennings, N. The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and its Implications. *International Review of Psychiatry* **34**, 443–498 (2022).
- ¹⁴ Roland, J., Kurek, N. & Nabarro, D. *Health in the climate crisis: A guide for health leaders*. (World Innovation Summit for Health, 2020).
- ¹⁵ Hickman, C. *et al.* Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. *The Lancet Planetary Health* **5**, e863–e873 (2021).
- ¹⁶ Chen, S. X., Lee, M., McVea, D. A. & Henderson, S. B. Risk of mortality among people with schizophrenia during the 2021 heat dome. *British Columbia Medical Journal* **65**, 158–9.

- ¹⁷ Page, L. A., Hajat, S., Kovats, R. S. & Howard, L. M. Temperature-related deaths in people with psychosis, dementia and substance misuse. *Br J Psychiatry* **200**, 485–490 (2012).
- ¹⁸ Woodland, L., Ratwatte, P., Phalkey, R. & Gillingham, E. L. Investigating the Health Impacts of Climate Change among People with Pre-Existing Mental Health Problems: A Scoping Review. *IJERPH* **20**, 5563 (2023).
- ¹⁹ Charlson, F. *et al.* Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. *IJERPH* **18**, 4486 (2021).
- ²⁰ World Health Organization (WHO). 2021 *WHO Health and Climate Change Survey Report*. (World Health Organization, 2021).
- ²¹ Romanello, M. *et al.* The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. *The Lancet* **400**, 1619–1654 (2022).
- ²² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (Cambridge University Press, 2023).
- ²³ Knutson, T. *et al.* Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part II: Projected Response to Anthropogenic Warming. *Bulletin of the American Meteorological Society* **101**, E303–E322 (2020).
- ²⁴ WHO. *Climate Change and Health in Small Island Developing States: WHO Special Initiative in collaboration with UNFCCC Secretariat and Fijian Presidency of COP-23*. 1–18 www.who.int/publications/m/item/climate-change-and-health-in-small-island-developing-states (2018).
- ²⁵ Centre for Epidemiology and Evidence. *Setting Research Priorities: A Guide*. (Population and Public Health Division, NSW Ministry of Health, 2023).
- ²⁶ CRED. EM-DAT: The International Disaster database. <https://www.emdat.be/> (2023).